



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN KEGIATAN

KOMITE MUTU RS. PRIMA HUSADA SUKOREJO

**BULAN MEI
TAHUN 2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN KEGIATAN KOMITE MUTU BULAN Mei RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2026

Dalam pembangunan sektor kesehatan, salah satu prakondisi yang harus dipenuhi adalah meningkatkan mutu pelayanan, termasuk mutu pelayanan di rumah sakit agar pengelolaan rumah sakit menjadi lebih efektif dan efisien. Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit prima Husada Sukorejo disusun berdasarkan program kerja yang telah disepakati bersama oleh direktur dan seluruh stake holder yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Disusun Oleh :

Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo

Sukorejo, 31 Mei 2026

Telah Disetujui Oleh :

Direktur PT. Disa Prima Medika



(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE)

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN KOMITE MUTU BULAN MEI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2026

Laporan Kegiatan Komite Mutu RS. Prima Husada digunakan sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan Rencana perbaikan kinerja maupun layanan di unit Kerja Rumah Sakit Prima Husada

Disusun,
Oleh ;
Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo



(Ns. Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep)

Disetujui oleh,
Authorized Person



(Dr.dr.Aslichah M.Kes., AFP, CHAE.)

Disetujui,
Oleh

Direktur RS. Prima Husada Sukorejo



(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, SWT karena atas Rahmat-Nya Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Bulan Mei Tahun 2026 telah dapat diselesaikan. Laporan ini berisikan kumpulan dari program kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang menjangkau keseluruhan unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/bagian, keperawatan, penunjang medis, administrasi dan lainnya termasuk kepala unit / instalasi pelayanan.

Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Bulan Mei Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada bulan berikutnya.

Akhir kata, kami dari Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh program dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sehingga tersusunnya laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Bulan Mei Tahun 2026. Semoga dengan adanya laporan ini kita dapat meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Penyusun

Komite Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN 1

DAFTAR ISI 4

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

 1.2 Tujuan 1

 1.2.1 Tujuan Umum..... 1

 1.2.2 Tujuan Khusus 1

BAB II..... 2

HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN KOMITE MUTU..... 2

BULAN MEI TAHUN 2026 2

 2.1 Kegiatan Pokok..... 2

 2.2 Kegiatan yang Dilakukan 3

 2.3 Jadwal Kegiatan..... 3

 2.4 Pencatatan dan Pelaporan 3

BAB III..... 1

HASIL KEGIATAN 1

 3.1 Pemantauan Indikator Mutu 1

 3.1.1 Indikator Mutu Nasional 1

 3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional..... 1

 3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit 1

 3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo..... 1

 3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit 1

8. MATERNITAS 16

9. PONEK 19

10. NEONATOLOGI..... 22

11. ICU..... 24

12. RADIOLOGI..... 26

13. LABORATORIUM 27

14. REHAB MEDIS 29

15. FARMASI 31

16. GIZI 33

17. REKAM MEDIS 34

18. LIMBAH – K3RS	36
19. SDM.....	37
20. KESEKRETARIATAN.....	38
21. DRIVER.....	39
22. PEMULASARAN JENAZAH.....	39
23. ATEM – IPSRS	40
24. LAUNDRY	41
25. CSSD.....	41
26. CLEANING SERVICE	44
27. KEAMANAN	45
28. GUDANG UMUM	46
29. PPI	46
30. PKRS.....	48
31. ASURANSI CENTER	50
32. HUMAS & MARKETING	51
33. CSO	51
34. MOD-MPP-PIPP	52
35. TB di IRJA.....	52
36. TIM HIV	53
37. KB	53
38. STUNTING	54
39. IT - SIM RS	55
40. HEMODIALISA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi RS Prima Husada Sukorejo adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi RS Prima Husada Sukorejo, maka ditetapkan tiga misi sebagai berikut: (1) memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat, (2) mengutamakan kepuasan pasien, (3) meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Untuk memberikan pelayanan dengan mengutamakan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien RS Prima Husada Sukorejo melakukan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang sesuai dengan Standar Akreditasi Nasional. Kegiatan ini dilakukan di semua unit kerja untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo pada tahun 2026 menetapkan indikator rumah sakit sesuai standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dari KARS STARKES berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikannya indikator rumah sakit sebagai berikut : Indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas Rumah sakit (IMP-RS) yang meliputi : indikator sasaran keselamatan pasien, indikator pelayanan klinis prioritas, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, indikator terkait perbaikan sistem dan indikator terkait manajemen resiko, kemudian yang ketiga yakni insikator mutu prioritas unit.

Identifikasi prosedur, proses dan hasil dari kegiatan yang dinilai sebelumnya pada tahun 2025, disertai tujuan untuk menekan permasalahan yang ada di rumah sakit mendasari dipilihnya indikator baru di indikator prioritas. Kriteria pemilihan tetap didasarkan pada kasus yang memiliki volume tinggi, resiko tinggi atau biaya tinggi, disesuaikan dengan visi dan misi rumah sakit. Laporan Komite Mutu pada Bulan Mei Tahun 2026 terkait indikator mutu diambil oleh unit kerja.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di setiap unit di RS Prima Husada Sukorejo

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi peningkatan mutu RS Prima Husada Sukorejo melalui pemantauan indikator mutu internal atau eksternal berdasarkan standar Komite Mutu Tahun 2025
2. Mengevaluasi program keselamatan pasien dengan pemantauan Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit (IKP-RS)
3. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu lain, yang dilakukan oleh unit terkait dengan peningkatan mutu yakni:
 - a. Program manajemen resiko
 - b. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unit kerja
4. Menganalisis capaian indikator mutu unit untuk mendapatkan bahan rekomendasi sebagai rencana tindak lanjut perbaikan di unit

BAB II
HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN KOMITE MUTU
BULAN MEI TAHUN 2026

2.1 Kegiatan Pokok

Seperti yang dijelaskan di atas, kegiatan pemantauan indikator mutu Komite Mutu Tahun 2026 yang dilaporkan adalah periode Bulan Mei Tahun 2026. Adapun indikator mutu yang dipantau adalah sebagai berikut:

A) Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan
2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
3. Kepatuhan Identifikasi Pasien
4. Waktu Tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit
5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit
6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit
7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter Spesialis $\leq$ jam 14.00
8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit
9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)
11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh
12. Keterlambatan Respon Terhadap Komplain
13. Kepuasan Pasien

B) Indikator Mutu Prioritas

1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien
 - b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR
 - c. Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert
 - d. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien
 - e. Kepatuhan Kebersihan Tangan
 - f. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
2. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
 - a. Kepatuhan PPK/CP DM Gangren/Ulcus dengan Tindakan Debridement
3. Indikator Berdasarkan Renstra RS
 - a. Presentase Pasien Komplain
 - b. Waktu Tunggu IGD ke Rawat Inap yakni ≤ 6 jam
4. Indikator Perbaikan Sistem
 - a. Waktu Tunggu Layanan Farmasi Obat Jadi < 30 menit
 - b. Waktu Tunggu Layanan Farmasi Obat Racikan < 60 menit
5. Indikator Manajemen Resiko
 - a. Presentase Berkas Pending Klaim
 - b. Angka Kerusakan Alat Medis karena Ketidaktepatan staf dalam Menjalankan SPO
6. Praktik Klinis yang Di Evaluasi (17 Diagnosis yang di evaluasi)
 - 1) Typhoid Fever (Dewasa dan Anak)
 - 2) Dengue Fever (Dewasa dan Anak)
 - 3) Pneumonia Dewasa
 - 4) Pneumonia Bayi dan Anak
 - 5) DM Gangren/Ulcus dan Tindakan Debridement
 - 6) Soft Tissue Tumor dengan tindakan eksisi
 - 7) Batu Ureter
 - 8) Diabetes Millitus
 - 9) GEA
 - 10) HIV
 - 11) Hipertensi
 - 12) TB
 - 13) Keganasan (Ca Mammae)
 - 14) Pneumonia
 - 15) SC
 - 16) Partus Normal
 - 17) PEB
 - 18) BPH

- 19) Hydronefrosis
- 20) PPOK
- 21) Fraktur terbuka
- 22) Stroke hemoragik
- 23) Stroke Trombosis

2.2 Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan analisis hasil capaian mutu indikator di unit kerja
3. Melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan capaian atau mencapai target yang ditentukan
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu di unit kerja
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

2.3 Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu di unit kerja secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu (dilakukan setiap bulan)
3. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator di unit kerja setiap bulan, serta menyusun program perbaikan mutu dengan teknik PDSA oleh penanggungjawab penggumpul data unit di koordinasikan dengan komite Mutu
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap satu bulan.
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo dengan hasil banchmarking perbandingan capaian mutu dengan RS lain setiap tiga bulan sekali.

2.4 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh penanggungjawab data mutu unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab. Data hasil pemantauan ditulis pada form laporan harian mutu dan dilakukan validasi kepada kepala unit untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah benar dan valid. Jika data sudah valid selanjutnya akan dilakukan analisis data untuk mencari rencana tindak lanjut bagi indikator mutu yang masih belum mencapai target atau standar yang ditetapkan. Hasil pengolahan dan analisis data dituangkan dalam laporan tertulis kemudian akan dilaporkan kepada penanggungjawab mutu rumah sakit setiap bulan dalam rapat koordinasi mutu bulanan.

Penanggung jawab mutu Rumah Sakit selanjutnya akan menentukan langkah untuk membuat rencana tindak lanjut indikator mutu yang belum sesuai targert sebagai bentuk feedback dari pelaporan penanggung jawab mutu di unit.

BAB III
HASIL KEGIATAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu

Berikut merupakan hasil pemantauan indikator mutu RS. Prima Husada Sukorejo yang dilakukan pada Bulan Mei Tahun 2026.

3.1.1 Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026.

Tabel 3.1 Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	≥80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	≤5%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	≥80%
8	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Kepuasan Pasien	≥76.61%

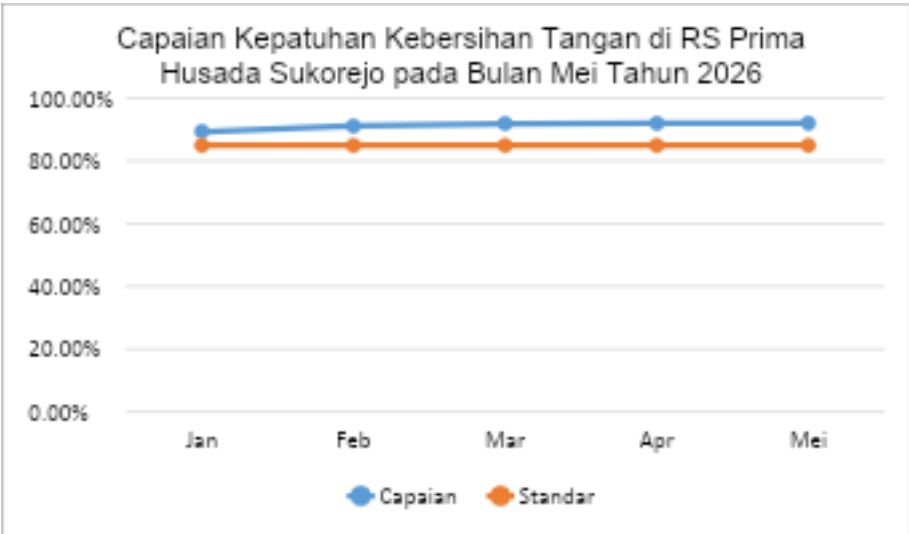
Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Bulan Mei Tahun 2026

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	89,40 %	91,13 %	91,92 %	92%	92,06 %								≥85%	91,30%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	96,54 %	93,82 %	94,98 %	98,94 %	97,15 %								100%	96,29%	PDSA
3	Kepatuhan identifikasi pasien	99,04 %	99,51 %	99,51 %	99,76 %	99,54 %								100%	99,47%	PDSA
4	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit	80%	80%	78,13 %	60%	65,38 %								≥80%	72,70%	PDSA
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	98,12 %	85,61 %	85,83 %	85,93 %	57,61 %								≥80%	82,62	Dipertahankan
6	Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit	2,14%	1,28%	1,14%	1,57%	2,81%								≤5%	1,79%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00 WIB)	66,21 %	72,78 %	72,05 %	69,90 %	74,47 %								≥80%	71,08%	PDSA
8	Waktu Laporan Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	98,24 %	98,91 %	98,05 %	100%	100%								≥80%	99,04%	Dipertahankan
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	99,39 %	99,53 %	99,60 %	85,34 %	89,47 %								≥80%	94,67%	Dipertahankan
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	98,02 %	98,09 %	98,04 %	96,82 %	98%								100%	97,79%	PDSA
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	96,15 %	94,74 %	81,82 %	88,89 %								≥80%	100%	Dipertahankan
13	Kepuasan Pasien	91,80 %	88,10 %	89,74 %	92,59 %	91,07 %								≥76.61%	90,66%	Dipertahankan

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

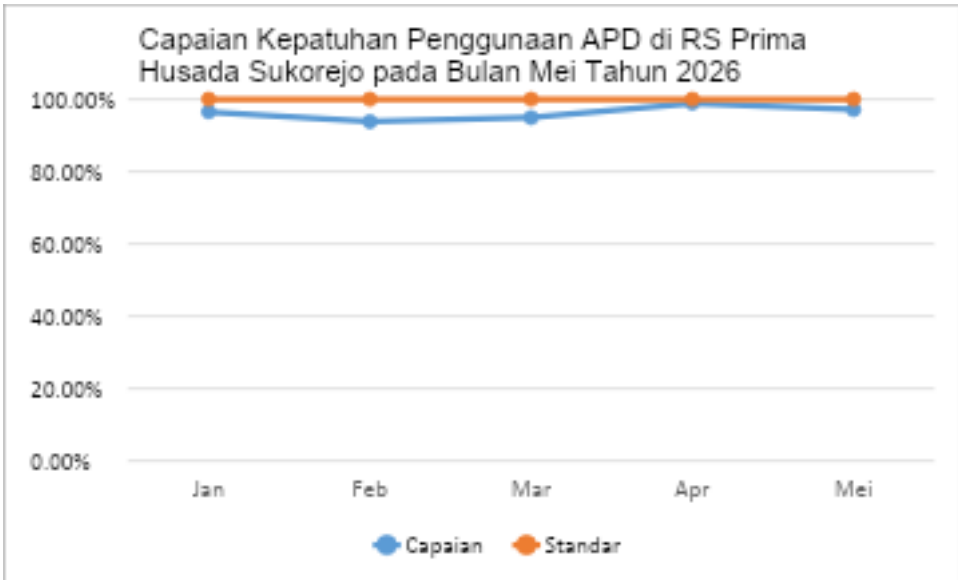


Gambar 3.1. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Bulan Mei yakni mencapai 92,06%. Dari 1159 petugas yang diobservasi yang melakukan patuhan dengan benar yakni 1067 petugas. Capaian sebesar **92,06%** ini menandakan bahwa mayoritas petugas (1067 dari 1159 orang) telah menerapkan prosedur cuci tangan sesuai dengan protokol yang berlaku. Meskipun angka ini sudah berada di kategori tinggi, upaya monitoring dan evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan konsistensi dan mencegah resistensi dari petugas yang masih belum patuh.

2. Kepatuhan Penggunaan APD



Gambar 3.2. Capaian Kepatuhan Penggunaan APD di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan data capaian kepatuhan penggunaan APD diatas pada Bulan Mei yakni mencapai 97,15%. Dari 843 petugas yang diobservasi terkait kepatuhan penggunaan APD, 819 petugas patuh dalam pemakaian APD.

Tabel 3.3 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Bulan Mei Tahun 2026

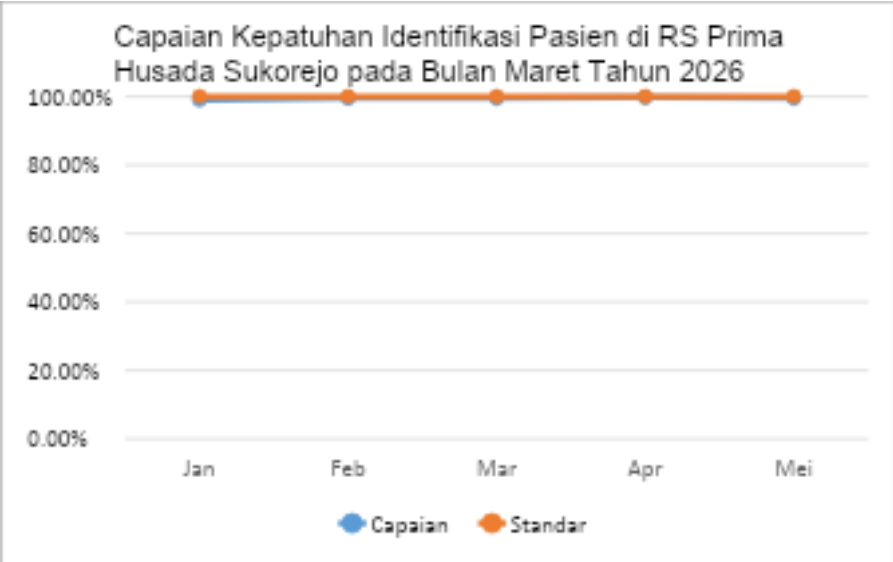
Problem	Capaian kepatuhan APD bulan Mei sebesar 97,15%, masih belum mencapai standar
---------	--

	(100%). Kepatuhan penggunaan APD menunjukkan tren selama 4 bulan terakhir, namun pada bulan Mei mengalami penurunan sebesar 1,79%. Prosentase ini perlu dikaji untuk diketahui akar dari masalah yang menyebabkan penurunan.
Step	1. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kepatuhan penggunaan APD secara konsisten di seluruh unit 2. Penguatan edukasi risiko infeksi bagi petugas
Plan	1. Objective: Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD serta memonitoring pelaporan kepatuhan berjalan konsisten secara real time di seluruh unit 2. Rencana intervensi: - Melakukan audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala (harian/mingguan) - Memberikan edukasi penyegaran terkait SPO APD 3. Harapan: Meningkatnya kepatuhan penggunaan APD secara konsisten yang terlihat dari grafik tren naik hingga 100% serta teridentifikasinya unit dengan variasi capaian
Do	1. Melaksanakan audit mendadak oleh Tim PPI di unit pelayanan 2. Memberikan edukasi dan teguran on-the-spot kepada petugas yang ditemukan tidak patuh menggunakan APD
Study	1. Hasil Kuantitatif: Capaian Mei 97,15% (819/843). Selain prosentase menunjukkan penurunan dari bulan sebelumnya, nilai ini dianggap belum mencapai standar yakni 100%. 2. Hasil audit akan dianalisis untuk melihat tren kepatuhan penggunaan APD selama periode observasi serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan, termasuk aspek kenyamanan, ketersediaan APD, dan perilaku petugas.
Action	1. Jika intervensi terbukti meningkatkan kepatuhan, maka audit kepatuhan APD akan dipertahankan sebagai metode monitoring rutin 2. Jika masih rendah, pendekatan edukasi dan teguran langsung akan diperkuat dengan umpan balik berbasis data kepada kepala unit untuk meningkatkan pengawasan internal

Tabel 3.4 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksanaan	Waktu
1	Melaksanakan audit kepatuhan APD secara rutin (harian/mingguan) sesuai jadwal monitoring	Menjaga keberlanjutan peningkatan kepatuhan APD	Seluruh unit pelayanan	Monitoring rutin berbasis checklist kepatuhan APD dan pelaporan hasil audit secara berkala	Tim PPI	1 bulan
2	Penyampaian umpan balik hasil audit kepatuhan APD kepada kepala unit secara rutin	Meningkatkan pengawasan internal dan tanggung jawab kepala unit terhadap kepatuhan APD	Kepala unit pelayanan	Feedback berbasis data hasil audit (grafik/tren kepatuhan) disampaikan secara periodik dan dibahas dalam forum evaluasi unit	Komite PMKP dan PPI	1 bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei 2026 mencapai 99,54%. Dari 6483 petugas yang diobservasi ditemukan 6453 petugas yang patuh terhadap identifikasi pasien. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.5 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan Mei Tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Mei terdapat penurunan sebesar 0,22% jika dibandingkan dengan bulan April dengan capaian 99,54%, masih ditemukan 30 petugas (0,46%) dari 6483 observasi yang belum patuh. Ditemukan bahwa petugas tidak melakukan pengecekan gelang identitas sebelum melakukan tindakan krusial seperti: a. Pemberian Injeksi (Analgesik/Obat lain) b. Edukasi Relaksasi Napas Dalam c. Pengambilan Sampling Darah d. Pemeriksaan Gula Darah (GDA) e. Monitoring TTV f. Pemasangan Infus g. Transfusi Darah h. Pemberian Nebulisasi Hal ini menunjukkan adanya gap antara "bertanya nama" dengan "verifikasi identitas pada gelang", yang merupakan standar baku keselamatan pasien
Step	1. Mengidentifikasi data <i>by name</i> dan unit asal dari 30 petugas yang tidak melakukan verifikasi gelang untuk memetakan area dengan risiko tertinggi. 2. Melakukan wawancara kepada 30 petugas terkait dengan alasan ketidakpatuhan dalam melakukan identifikasi pasien.
Plan	1. Objective: Mencapai 100% verifikasi gelang pada setiap tindakan medis dan keperawatan. 2. Rencana intervensi: - Mewajibkan ritual "Lihat, Baca, dan Cocokkan" sebelum menyentuh pasien untuk tindakan apa pun. - Menjadwalkan kehadiran perwakilan Komite PMKP pada rapat rutin bulanan di setiap unit pelayanan untuk penyampaian data dan validasi akar masalah.
Do	1. Edukasi "On-the-Spot": Menegur langsung saat petugas terlihat hanya bertanya nama tanpa melihat gelang saat akan melakukan tindakan 2. Menyerahkan data (<i>by name</i>) kepada Kepala Unit untuk dilakukan pembinaan mengenai identifikasi pasien 3. Perwakilan Komite PMKP menghadiri rapat dan mengevaluasi capaian mutu

Study	- Hasil Analisis: Petugas cenderung melewati cek gelang pada tindakan rutin (seperti monitoring TTV atau GDA) karena merasa sudah mengetahui pasien yang hendak diperiksa, dan merasa sungkan jika sering validasi identitas pada pasien padahal kesalahan identitas pada TTV atau GDA tetap dapat mengakibatkan salah diagnosa dan salah terapi oleh dokter. - Tindakan seperti "Pemberian Terapi Obat (Oral/Injeksi)" dan "Sampling Darah" adalah titik kritis yang paling berbahaya jika gelang tidak dicek.
Action	- Menstandarisasi paparan data ketidakpatuhan dalam agenda tetap rapat rutin unit (IGD, IKO, Rawat Inap) sebagai bentuk transparansi mutu. - Mengintegrasikan kepatuhan identifikasi pasien ke dalam Indikator Kinerja Individu agar menjadi syarat dalam penilaian berkala seluruh staf medis dan keperawatan.

Tabel 3.6 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Menstandarisasi paparan data ketidakpatuhan dalam agenda tetap rapat rutin unit (IGD, IKO, Rawat Inap) sebagai bentuk transparansi mutu.	Memaparkan data data ketidakpatuhan secara transparan dan mengidentifikas i kendala spesifik di lapangan.	Kepala Unit dan seluruh staf klinis (Rawat Inap, IGD, IKO, dll)	Diseminasi Data Faktual: Menyajikan perbandinga n data kepatuhan antar unit dan diskusi solusi atas kendala "tidak cek gelang" atau "tidak terpasang gelang identitas"	Komite PMKP	1 bulan
2	Mengintegrasika n kepatuhan identifikasi pasien ke dalam Indikator Kinerja Individu agar menjadi syarat dalam penilaian berkala seluruh staf medis dan keperawatan.	Meningkatkan kedisiplinan staf dan memastikan prosedur "Lihat, Baca, Cocokkan" dijalankan 100%.	Staf yang tidak patuh dalam observasi.	Kepala Ruangan memasukkan poin pelanggaran identifikasi ke dalam evaluasi kinerja staf.	Kepala Ruangan	Periode penilaiain kinerja berjalan

4. Waktu Tunggu Operasi Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 Menit



Gambar 3.4. Capaian Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency ≤ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan grafik capaian waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergency kurang dari 30 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026 belum mencapai standar yakni 65,38% walaupun prosentase ini meningkat sebesar 5,38% dari bulan sebelumnya. Dari 26 pasien yang diobservasi, masih terdapat 9 pasien yang mendapatkan pelayanan tanggap SC Emergency diatas dari 30 menit. Secara keseluruhan Pelayanan Ponek, IGD, Maternitas dan IKO dapat melakukan koordinasi dengan baik sehingga hampir seluruh operasi dilakukan secara tepat.

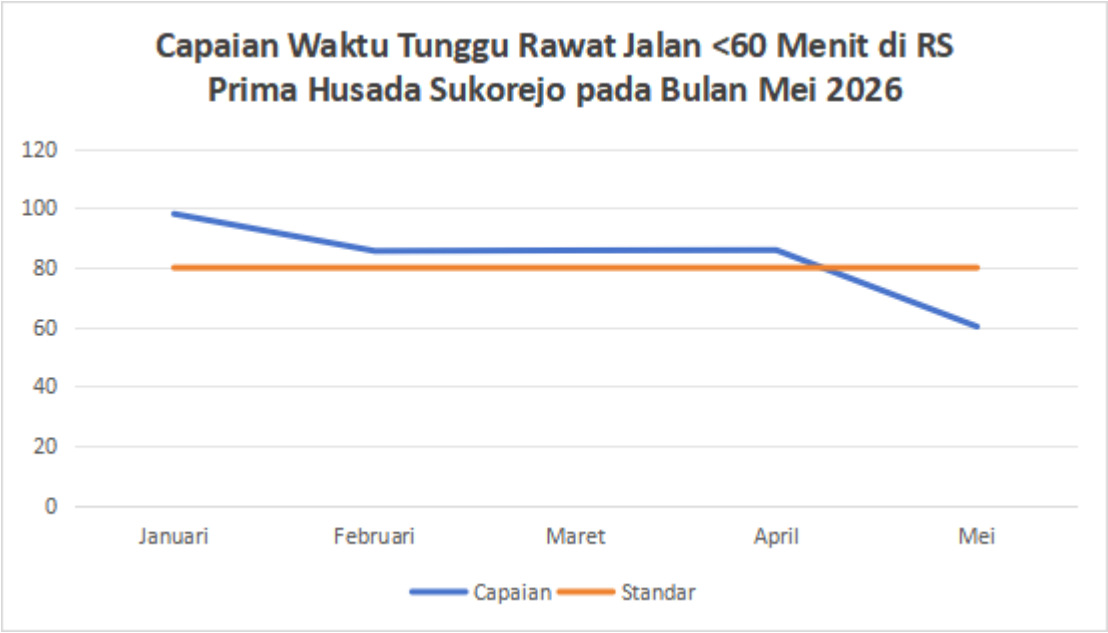
Tabel 3.7 PDSA Capaian Waktu Tanggap SC Emergency ≤ 30 Menit pada Bulan Mei Tahun 2026

Problem	Capaian waktu tanggap SC Emergency ≤ 30 Menit pada bulan Mei adalah 65,38%. Capaian ini mengalami peningkatan dari bulan ke bulan.
Step	1. Mengidentifikasi alasan keterlambatan waktu tanggap SC Emergency melalui data laporan dan wawancara PIC dari unit Maternitas dan Ponek. 2. Hasilnya berkaitan dengan status dokter tamu yang perlu persiapan ketika ada rencana untuk tindakan SC Emergency yang diketahui jarak tempuh dari kediaman dokter ke RS rata-rata memakan waktu > 30 menit sehingga target sulit tercapai
Plan	1. Objective: mencapai target waktu SC Emergency ≤ 30 menit 2. Melakukan sosialisasi dan supervisi terhadap kepatuhan waktu tanggap SC Emergency ≤ 30 Menit
Do	1. Melakukan pertemuan koordinasi dengan tim Ponek dan Maternitas untuk menyosialisasikan pentingnya kepatuhan waktu tanggap ≤ 30 menit. 2. Melakukan supervisi langsung pada saat terjadi kasus SC Emergency untuk memastikan prosedur pemanggilan dokter dilakukan tepat waktu.
Study	Kasus keterlambatan disebabkan oleh status dokter tamu yang terhalang oleh jarak tempuh DPJP yang > 30 menit karena pada saat Emergency DPJP tidak di Rumah Sakit
Action	1. Kolaborasi dengan SDM terkait pemetaan DPJP saat ada SC Emergency 2. Supervisi dan evaluasi secara berkala

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Kolaborasi dengan SDM terkait pemetaan DPJP saat ada SC Emergency	Meningkatkan peluang untuk tercapainya Waktu Tanggap SC Emergency ≤ 30 Menit	Seluruh staf Ponek, OK, Anestesi, dan DPJP Obgyn	Melakukan pemetaan terkait kejadian SC Emergency dan ketersediaan DPJP, sosialisasi ulang mengenai SPO SC Emergency < 30 menit	Komite PMKP & Kepala Ruangan	1 bulan
2	Supervisi dan evaluasi secara berkala	Memastikan kepatuhan prosedur di lapangan	Memastikan kepatuhan prosedur di lapangan	Melaksanakan Supervisi langsung pada setiap kasus SC Cito untuk memantau waktu respon mulai dari keputusan dokter sampai insisi	Komite PMKP & Kepala Ruangan	Periode penilaian kinerja berjalan

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit



Gambar 3.5. Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu rawat jalan di RS. Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026 mencapai 57,61%. Hasil capaian ini berarti dari total pasien yang terdaftar dan menunggu poli, yakni 4.570 pasien. Total pasien yang berhasil menunggu dan dilayani dokter dalam waktu kurang dari 60 menit adalah sebanyak 2.633 pasien. Capaian 57,61% ini **menurun** dari standar minimum yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kementerian Kesehatan, yaitu ≥ 80%. Dengan rata – rata waktu tunggu poli yakni 58 menit. Data ini diambil dalam fitur **Antrian Online** dari **Mobile JKN**.

Capaian diatas mengartikan pemanfaatan fitur **Antrian Online** dari **Mobile JKN** di rumah sakit sedang mengalami penurunan. Data yang diambil langsung dari *database* BPJS lebih akurat, mengurangi waktu yang terbuang untuk koreksi data administrasi.

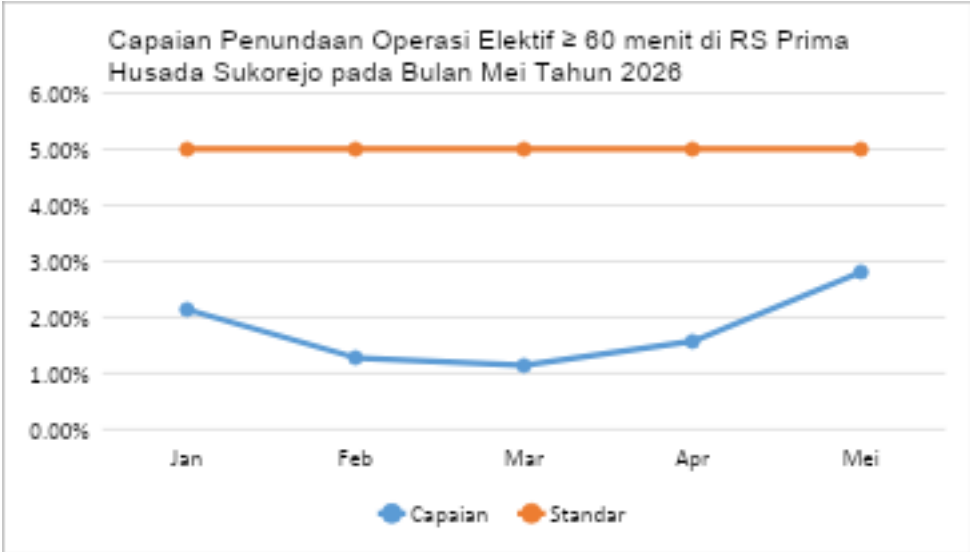
Tabel 3.9 PDSA Capaian Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit pada Bulan Mei Tahun 2026

Problem	Capaian waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit pada bulan Mei adalah 57,61%. Capaian ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya.
Step	1. Mengidentifikasi alasan penurunan capaian waktu tunggu rawat jalan < 60 menit melalui wawancara dengan PIC dari unit IRJA, Pendaftaran dan Asuransi Center. 2. Hasilnya berkaitan dengan status dokter tamu yang perlu persiapan sebelum melakukan pelayanan poli. Selain itu kurangnya pemanfaatan MJKN dalam pendaftaran antrean juga menjadi poin dalam penurunan capaian.
Plan	1. Objective: mencapai target waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit 2. Sosialisasi dan supervisi terhadap kepatuhan DPJP dalam pelayanan Poliklinis sesuai dengan jadwal HFIS
Do	1. Melakukan pertemuan koordinasi dengan tim IRJA dan pendaftaran untuk menyosialisasikan pentingnya perhatian waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit. 2. Melakukan audit pada saat jam kunjungan poliklinis untuk mengetahui ketepatan dalam penggunaan antrean online dan ketepatan kehadiran jam dokter sesuai dengan HFIS.
Study	Peningkatan waktu tunggu rawat jalan disebabkan oleh ketidakdisiplinan dokter dalam pelayanan poliklinis. Dokter tidak hadir sesuai dengan jadwal HFIS yang sudah ada
Action	1. Kolaborasi dengan SDM untuk mengetahui kedisiplinan dokter dalam mematuhi jadwal HFIS 2. Supervisi dan evaluasi secara berkala

Tabel 3.10 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Kolaborasi dengan SDM untuk mengetahui kedisiplinan dokter dalam mematuhi jadwal HFIS	Meningkatkan peluang untuk tercapainya Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 Menit	Rawat Jalan	Melakukan sosialisasi ulang mengenai jadwal HFIS dan pentingnya waktu tunggu rawat jalan	Komite PMKP & Kepala Ruangan	1 bulan
2	Supervisi dan evaluasi secara berkala	Memastikan kepatuhan prosedur di lapangan	Rawat Jalan	Melaksanakan audit terhadap kepatuhan dokter dalam pelayanan Poliklinis, sejak pasien datang hingga mendapatkan pelayanan	Komite PMKP & Kepala Ruangan	Periode penilaian kinerja berjalan

6. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit



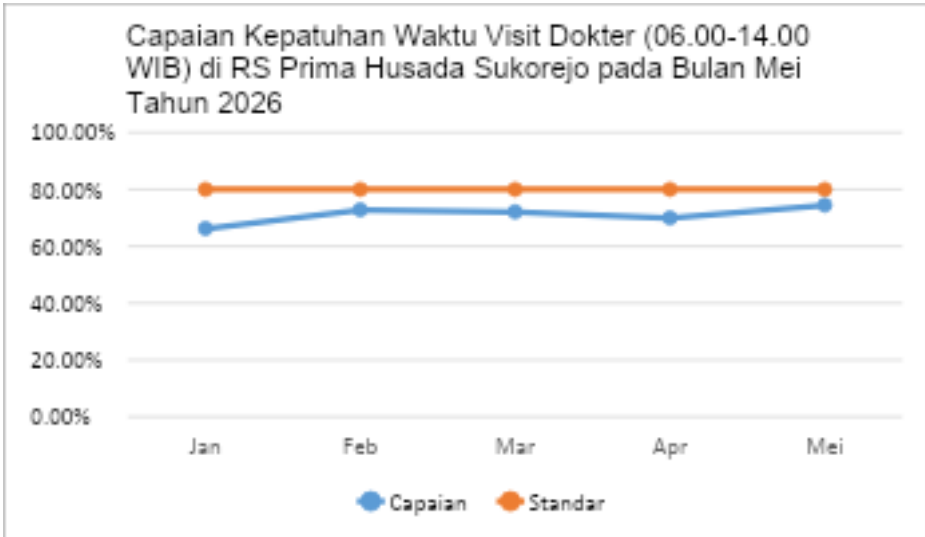
Gambar 3.6. Capaian Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026.

Analisis:

Berdasarkan grafik capaian penundaan operasi elektif lebih dari 60 menit di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei tahun 2026 yakni 2,81%. Capaian ini sudah mencapai standar <5%. Ini dikarenakan dari 285 pasien yang diobservasi 8 pasien dengan operasi elektif yang mengalami penundaan lebih dari 1 jam. Faktor pendukung keberhasilan ini dikarenakan:

- a. Kesiapan pasien: proses administrasi, pemeriksaan penunjang (laboratorium/rontgen) dan puasa pasien dilakukan dengan tepat
- b. Kehadiran dokter operator, dokter anestesi dan perawat tim IKO tepat sesuai jadwal
- c. Ketersediaan alat bedah yang steril siap digunakan tepat waktu sesuai antrean operasi
- d. Perpindahan pasien dari ruang rawat inap ke ruang IKO sesuai jadwal

7. Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis ≤ jam 14.00 WIB



Gambar 3.7. Capaian Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00-14.00 WIB) di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kepatuhan waktu visite dokter spesialis kepada pasien rawat inap, diperoleh rata-rata capaian sebesar 71,08% belum memenuhi standar minimal $\geq 80\%$. Ini dikarenakan dari 852 yang dibservasi dalam visite ke pasien, hanya 605 pasien yang di visit dokter kurang dari jam 14.00 WIB.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Waktu Visite Dokter pada Bulan Mei Tahun 2026

Problem	Capaian waktu visite dokter spesialis pada bulan Mei 2026 sebesar 74,47%, masih di bawah standar minimal $\geq 80\%$. Dari 852 observasi, terdapat 247 pasien yang mendapatkan visite di atas jam 14.00 WIB. Kondisi ini berisiko menunda rencana terapi dan proses pemulihan pasien serta beresiko tinggi complain.
Step	1. Mapping Jadwal: Mengidentifikasi jam praktik dokter spesialis di RS lain untuk menentukan prioritas kunjungan pagi (Kolaborasi dengan Komdik) 2. Review Progress Rekrutmen: Melakukan koordinasi dengan bagian SDM mengenai status rekrutmen dokter ruangan (dokter organik) untuk mengisi kekosongan tenaga medis pendamping.
Plan	1. Objective: Meningkatkan kepatuhan visite menjadi $\geq 80\%$ dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. 2. Strategi: Mempercepat proses rekrutmen dokter ruangan dan meningkatkan peran perawat senior dalam memfasilitasi persiapan asuhan medis. 3. Strategi : Meningkatkan kemampuan komunikasi efektif sebagai upaya preventif terhadap complain 4. Strategi : Koordinasi dengan MOD supaya pasien dapat divisite sesuai dengan jadwal kunjungan
Do	1. Percepatan Rekrutmen: Bagian SDM memprioritaskan seleksi dokter ruangan dan rancangan dokter organik agar segera ada tenaga medis yang <i>standby</i> di RS. 2. Bidan/Perawat melakukan konfirmasi (reminder) via WhatsApp kepada dokter spesialis pada awal shift pagi dan followup pada shift berikutnya 3. Perawat ruangan secara aktif menyiapkan kelengkapan pemeriksaan (berkas/hasil penunjang) agar saat dokter spesialis datang di sela jadwal praktiknya, proses visite bisa berlangsung lebih cepat.
Study	Apa yang anda pelajari? Apakah sesuai target capaian? 1. Capaian bulan Mei sebesar 71,08% masih berada di bawah target standar minimal $\geq 80\%$. 2. Mayoritas dokter spesialis adalah dokter tamu yang memiliki jadwal praktik di Rumah Sakit lain atau Klinik pada jam utama (06.00 – 14.00 WIB), sehingga waktu untuk melakukan visite di RS Prima Husada Sukorejo menjadi sangat terbatas dan sering tergeser ke atas jam 14.00 WIB. 3. Beban Kerja Tinggi: Terbatasnya jumlah dokter organik menyebabkan penumpukan beban visite pasien rawat inap pada dokter tamu yang memiliki mobilitas tinggi antar fasilitas kesehatan. 4. Dampak Operasional: Ketidakpatuhan waktu visite ini berdampak pada tertundanya rencana asuhan pasien (pemeriksaan penunjang/terapi) serta

	menghambat proses pemulangan pasien (<i>discharge</i>) tepat waktu serta berpotensi besar terhadap kejadian komplain.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan siklus PDSA yang telah dijalankan pada bulan Mei 2026, dapat disimpulkan bahwa: 1. Capaian kepatuhan waktu visite dokter spesialis (71,08%) belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan ($\geq 80\%$). 2. Akar masalah utama bersifat sistemik, yaitu adanya bentrok jadwal praktik dokter di fasilitas kesehatan lain pada jam utama (06.00–14.00 WIB). Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melaksanakan proses rekrutmen dokter organik di bulan Juni 2026. 2. Koordinasi dengan MOD dan Kabid jika ada dokter yang tidak visit sesuai dengan jadwal kunjungan dan menyebabkan penundaan pelayanan

Tabel 3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelaksanaan <i>Open Recruitment</i> (Rekrutmen Terbuka) Dokter Organik	Memenuhi kebutuhan Dokter Organik agar proses pendelegasi an visite di hari kerja (Senin-Jumat) dan Sabtu berjalan optimal tanpa membebani Dokter IGD.	Tenaga Medis	Mempublikasikan lowongan kerja secara luas dan melakukan seleksi cepat untuk mengisi posisi dokter spesialis <i>home-base</i> .	SDM dan Kabid Pelayanan Medis.	1 bulan
2	Koordinasi dengan MOD dan Kabid jika ada dokter yang tidak visit sesuai dengan jadwal kunjungan dan menyebabkan penundaan pelayanan	Memastikan seluruh pasien di visite oleh dokter sejawat dan sesuai dengan jadwal <14.00	Dokter Spesialis Komdik dan MOD	Melakukan koordinasi dengan DPJP sejawat terkait perwakilan visitasi	Komdik, MOD dan DPJP	1 bulan

8. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≤ 60 menit



Gambar 3.8. Capaian Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 30 menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan grafik capaian waktu lapor hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit pada Bulan Mei Tahun 2026 yakni 100% sesuai standar. Dari hasil kritis laboratorium di observasi, hasil tes kritis sudah dilaporkan kurang dari 30 menit. Unit Laboratorium telah menyampaikan hasil tes kritis laboratorium kurang dari 30 menit.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

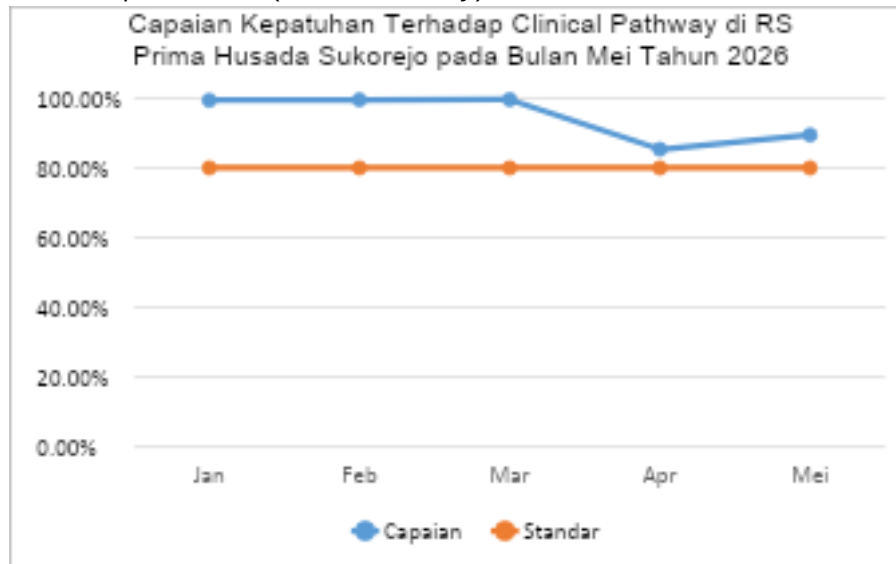


Gambar 3.9. Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan grafik capaian kepatuhan penggunaan formularium nasional di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026 telah mencapai standar yakni 100%. Unit Farmasi melakukan peresepan obat hanya dari Formularium Nasional. Dari 155 obat yang diobservasi, seluruhnya sudah sesuai dengan formularium nasional.

10. Kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)



Gambar 3.10. Capaian Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Mei Tahun 2026 sudah mencapai standar yakni 89,47%. Angka tersebut sudah mencapai target >80%. Adapun Kriteria yang diukur adalah LOS (*Length of Stay*), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Bulan Mei didapatkan dari diagnosa PEB, Partus Prematurus, Seksio Cesarea, TB Paru, Pneumonia, Bacterial Pneumonia, Debridement pada pasien dengan Gangrene DM dan Bronchopneumonia.

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Gambar 3.11. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Bulan Mei tahun 2026 adalah 98%, angka tersebut belum mencapai target 100% namun sudah meningkat dari bulan sebelumnya. Dari 1503 pasien yang diobservasi, 1473 pasien dilakukan upaya pencegahan resiko jatuh secara benar.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2026

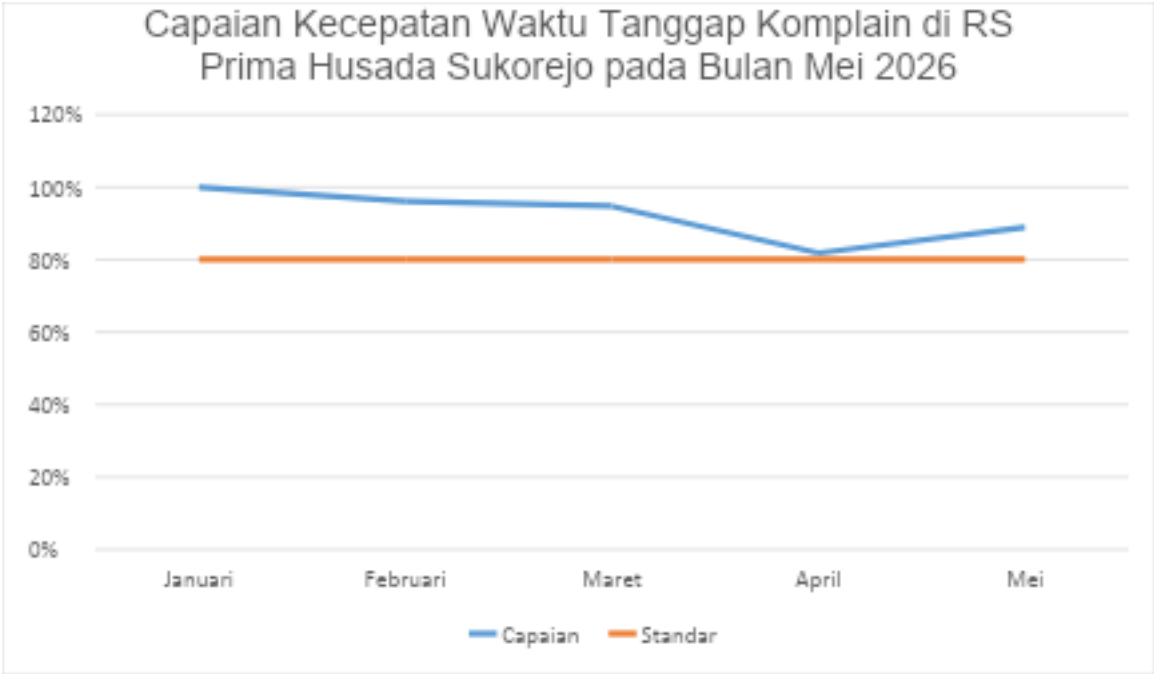
Problem	Capaian kepatuhan pencegahan risiko pasien jatuh pada bulan Mei 2026 sebesar 98%, masih di bawah target mutlak 100%. Dari 1503 pasien, terdapat 30 pasien (2%) yang tidak mendapatkan perlindungan risiko jatuh secara standar. Berdasarkan audit visual, ditemukan: 1. Pasien risiko tinggi tidak ada tanda risiko jatuh di bed pasien. 2. <i>Handrail</i> tempat tidur tidak terpasang/terkunci. 3. Kurangnya edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan jatuh. 4. Tidak identifikasi gelang pasien dengan risiko jatuh
Step	1. Audit Logistik: Memastikan ketersediaan stok stiker risiko jatuh di setiap <i>nurse station</i>. 2. Pengecekan Fasilitas: Melakukan inspeksi terhadap kondisi <i>handrail</i> tempat tidur di seluruh ruang perawatan untuk memastikan fungsi kuncinya masih baik.
Plan	1. Objective: Mencapai tingkat kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar 100% pada periode audit berikutnya melalui penguatan pengawasan fasilitas dan edukasi keluarga. 2. Strategi: Optimalisasi Penandaan: Mewajibkan pemasangan tanda resiko jatuh pada tempat tidur segera setelah skor asesmen menunjukkan risiko tinggi. Praktik DRK : Merefleksikan masalah atau temuan untuk menemukan akar masalah dan cara strategis untuk menanggulangnya
Do	1. Pemasangan Atribut: Petugas wajib memasang stiker kuning di bed pasien segera setelah asesmen awal menunjukkan skor risiko tinggi. 2. Perawat memberikan edukasi singkat kepada keluarga pasien mengenai cara menjaga <i>handrail</i> tetap terpasang dan cara memanggil bantuan dan didokumentasikan pada ERM.
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Ketidakpatuhan (2%) menurun dari bulan sebelumnya hal ini terjadi karena petugas sudah mulai mawas diri dengan melakukan edukasi tertulis dan melakukan supervisi pada setiap sarpras yang menyebabkan resiko jatuh pada pasien. 2. <i>Handrail</i> yang tidak terpasang sering kali disebabkan oleh keluarga pasien yang menurunkannya dan menjadi titik lengah perawat.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Bulan Mei Tahun 2026 belum sesuai standar yakni 98% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Rapat Koordinasi Unit: Memaparkan temuan 30 staf tidak patuh tersebut dalam rapat unit sebagai pengingat risiko cedera kepala atau patah tulang jika pasien jatuh. 2. Evaluasi Kinerja: Nama petugas yang bertanggung jawab pada 30 kasus ketidakpatuhan tersebut diserahkan kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam penilaian kinerja bulanan. 3. Redesign Monitoring: Mewajibkan pengecekan <i>handrail</i> menjadi bagian dari <i>checklist</i> operan perawat setiap pergantian <i>shift</i>. 4. Praktik DRK : Merefleksikan masalah atau temuan untuk menemukan akar masalah dan cara strategis untuk menanggulangnya bersama

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rapat Koordinasi Unit	Meningkatkan kesadaran staf mengenai urgensi pencegahan cedera (patah tulang/cedera kepala) akibat jatuh.	Seluruh staf klinis di unit rawat inap.	Memaparkan data 47 pasien tidak patuh secara transparan sebagai bahan evaluasi dan pengingat risiko klinis	Komite PMKP	1 bulan
2	Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Personal.	Memastikan akuntabilitas staf dalam menjalankan standar prosedur	30 Petugas yang teridentifikasi tidak patuh.	Performance Integration: Menyerahkan data <i>by name</i> kepada Kepala Ruangan untuk	Kepala Ruangan	1 bulan

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
		keselamatan pasien.		dimasukkan ke dalam poin penilaian kinerja bulanan.		
3	Redesign Monitoring melalui Checklist Operan.	Menjamin fasilitas keamanan (<i>handrail</i>) dan tanda risiko selalu terpasang di setiap pergantian <i>shift</i> .	Fasilitas tempat tidur pasien risiko tinggi.	Mewajibkan pengecekan fisik <i>handrail</i> dan stiker sebagai item wajib dalam <i>bedside handover</i> (operan di samping bed).	Perawat Pelaksana & Karu	1 bulan

12. Kepatuhan Waktu Tanggap Komplain

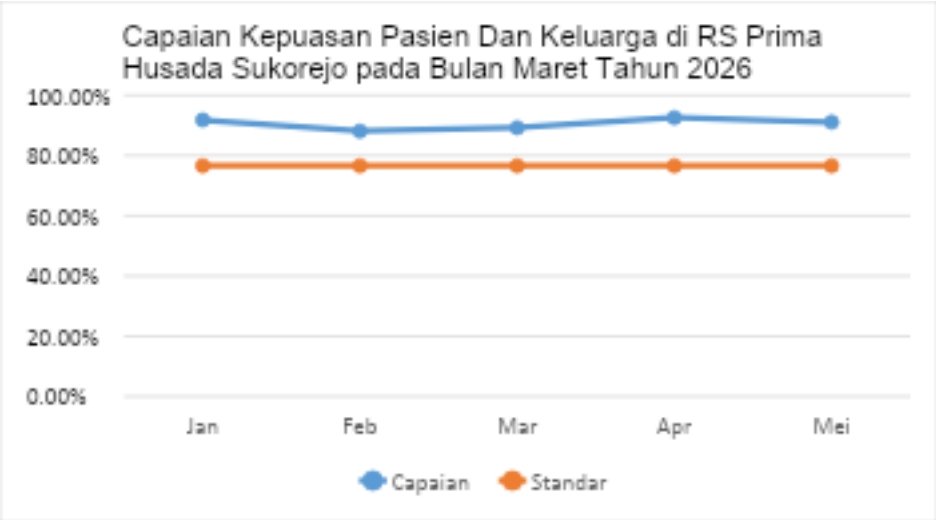


Gambar 3.12. Capaian Kecepatan Waktu Tanggap Komplain di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan grafik capaian kecepatan waktu tanggap complain pada Bulan Mei Tahun 2026 yakni 88,89% dan sesuai standar yakni ≥80%. Unit MOD-PIPP telah menindaklanjuti complain dari pasien.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.13. Capaian Kepuasan Pasien dan Keluarga di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Mei Tahun 2026 capaian Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 91,07%. Angka tersebut sudah mencapai target >76,61%.

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

Tabel 3.15 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Bulan Mei Tahun 2026

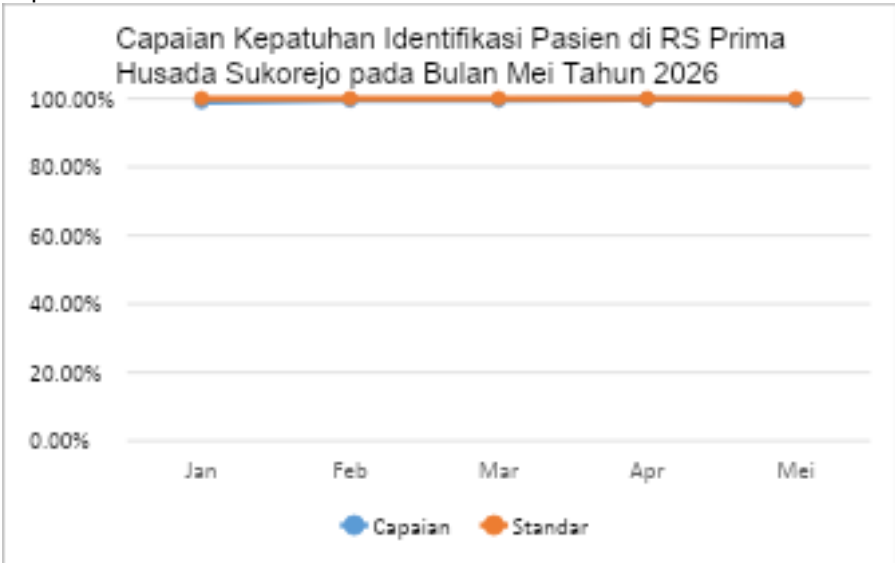
No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar: a. Kepatuhan Identifikasi pasien	99,04%	99,51%	99,51%	99,76%	99,54%								100%	99,47%	PDSA
		2. Meningkatkan komunikasi yang efektif: a. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	98,06%	98,28%	97,35%	99,43%	98,47%								100%	98,83%	PDSA
		3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (<i>High Alert Medications</i>): a. Kepatuhan staf farmasi dalam penempelan stiker LASA dan High Alert	-	-	-	90,17%	97,13%								100%	93,65%	PDSA
		4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur	-	-	-	-	98,3%								100%	98,3%	PDSA

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		yang benar, pembedahan pada pasien yang benar: a. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien															
		5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: a. Kepatuhan Kebersihan Tangan	89,40%	91,13%	91,92%	92%	92,06%								85%	91,30%	Dipertahankan
		6. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh: a. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,02%	98,09%	98,04%	96,82%	98%								100%	97,79%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	1. Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning pada pasien DM sebagai upaya mitigasi complain pasca rawat	-	-	-	-	-										Dipertahankan

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		2. Kepatuhan PPK/CP DM Tipe 2 dengan Komplikasi	-	-	-	-											Dipertahankan
3	Renstra RS	1. Presentase Pasien Complain	0,17%	0,27%	0,16%	0,19%	0,18%								0%	0,19%	PDSA
4	Perbaikan Sistem	1. Waktu tunggu layanan farmasi obat jadi < 30 menit	85,93%	84,17%	83%	86%	87,10%								≥80%	85,24%	Dipertahankan
		2. Waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit	75,56%	75%	70%	78%	73,51%								≥80%	74,41%	PDSA
5	Manajemen Resiko	1. Presentase berkas pending klaim	3,49%	3,81%	3,79%										<5%		
		2. Angka kerusakan alat medis karena ketidakpatuhan staf menjalankan SPO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

- 1. Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.14. Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei 2026 mencapai 99,54%. Dari 6483 petugas yang diobservasi ditemukan 6453 petugas yang patuh terhadap identifikasi pasien. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan secara konsisten telah menerapkan standar keselamatan pasien, khususnya dalam hal identifikasi menggunakan dua identitas yang benar (misalnya: nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis), sebelum melakukan tindakan medis maupun keperawatan.

Tabel 3.16 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Bulan Mei Tahun 2026

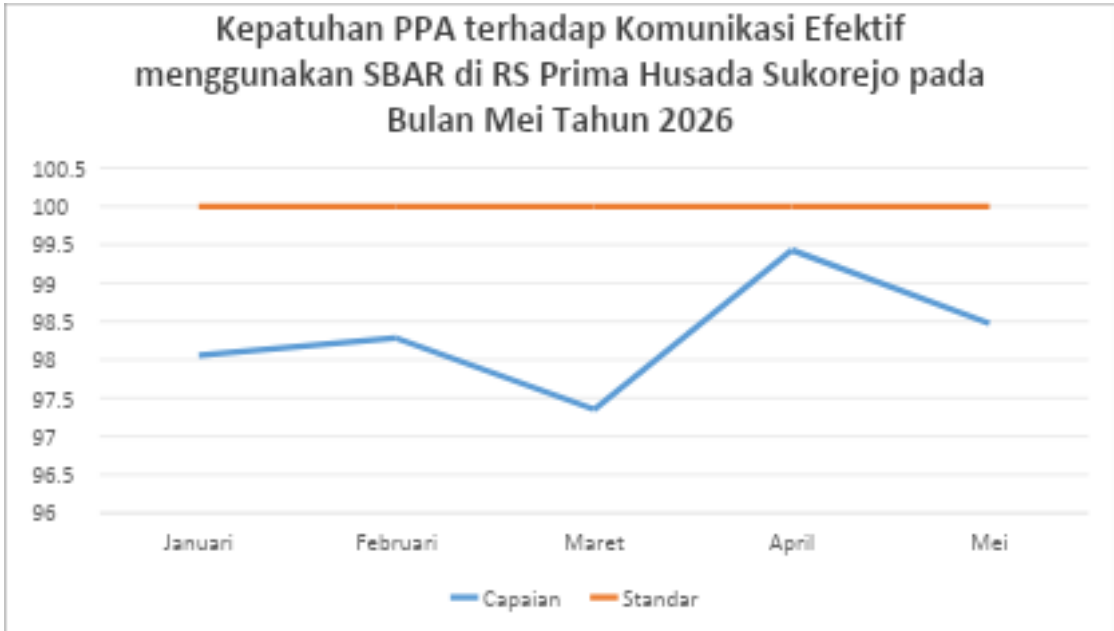
Problem	Capaian kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Mei terdapat penurunan sebesar 0,22% jika dibandingkan dengan bulan April dengan capaian 99,54%, masih ditemukan 30 petugas (0,46%) dari 6483 observasi yang belum patuh. Ditemukan bahwa petugas tidak melakukan pengecekan gelang identitas sebelum melakukan tindakan krusial seperti: i. Pemberian Injeksi (Analgesik/Obat lain) j. Edukasi Relaksasi Napas Dalam k. Pengambilan Sampling Darah l. Pemeriksaan Gula Darah (GDA) m. Monitoring TTV n. Pemasangan Infus o. Transfusi Darah p. Pemberian Nebulisasi Hal ini menunjukkan adanya gap antara "bertanya nama" dengan "verifikasi identitas pada gelang", yang merupakan standar baku keselamatan pasien
Step	3. Mengidentifikasi data <i>by name</i> dan unit asal dari 30 petugas yang tidak melakukan verifikasi gelang untuk memetakan area dengan risiko tertinggi. 4. Melakukan wawancara kepada 30 petugas terkait dengan alasan ketidakpatuhan dalam melakukan identifikasi pasien.
Plan	3. Objective: Mencapai 100% verifikasi gelang pada setiap tindakan medis dan keperawatan. 4. Rencana intervensi: - Mewajibkan ritual "Lihat, Baca, dan Cocokkan" sebelum menyentuh pasien untuk tindakan apa pun. - Menjadwalkan kehadiran perwakilan Komite PMKP pada rapat rutin bulanan di setiap unit pelayanan untuk penyampaian data dan validasi akar masalah.
Do	4. Edukasi "On-the-Spot": Menegur langsung saat petugas terlihat hanya bertanya nama tanpa melihat gelang saat akan melakukan tindakan

	5. Menyerahkan data (<i>by name</i>) kepada Kepala Unit untuk dilakukan pembinaan mengenai identifikasi pasien 6. Perwakilan Komite PMKP menghadiri rapat dan mengevaluasi capaian mutu
Study	3. Hasil Analisis: Petugas cenderung melewati cek gelang pada tindakan rutin (seperti monitoring TTV atau GDA) karena merasa sudah mengetahui pasien yang hendak diperiksa, dan merasa sungkan jika sering validasi identitas pada pasien padahal kesalahan identitas pada TTV atau GDA tetap dapat mengakibatkan salah diagnosa dan salah terapi oleh dokter. 4. Tindakan seperti "Pemberian Terapi Obat (Oral/Injeksi)" dan "Sampling Darah" adalah titik kritis yang paling berbahaya jika gelang tidak dicek.
Action	1. Menstandarisasi paparan data ketidakpatuhan dalam agenda tetap rapat rutin unit (IGD, IKO, Rawat Inap) sebagai bentuk transparansi mutu. 2. Mengintegrasikan kepatuhan identifikasi pasien ke dalam Indikator Kinerja Individu agar menjadi syarat dalam penilaian berkala seluruh staf medis dan keperawatan.

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Menstandarisasi paparan data ketidakpatuhan dalam agenda tetap rapat rutin unit (IGD, IKO, Rawat Inap) sebagai bentuk transparansi mutu.	Memaparkan data ketidakpatuhan secara transparan dan mengidentifikasi kendala spesifik di lapangan.	Kepala Unit dan seluruh staf klinis (Rawat Inap, IGD, IKO, dll)	Diseminasi Data Faktual: Menyajikan perbandingan data kepatuhan antar unit dan diskusi solusi atas kendala "tidak cek gelang" atau "tidak terpasang gelang identitas"	Komite PMKP	1 bulan
2	Mengintegrasikan kepatuhan identifikasi pasien ke dalam Indikator Kinerja Individu agar menjadi syarat dalam penilaian berkala seluruh staf medis dan keperawatan.	Meningkatkan kedisiplinan staf dan memastikan prosedur "Lihat, Baca, Cocokkan" dijalankan 100%.	Staf yang tidak patuh dalam observasi.	Kepala Ruangan memasukkan poin pelanggaran identifikasi ke dalam evaluasi kinerja staf.	Kepala Ruangan	Periode penilaian kinerja berjalan

b. Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR



Gambar 3.15. Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Mei Tahun 2026 yakni 98,47%. Meskipun angkanya tergolong tinggi capaiannya masih dibawah standar 100% dan menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dari 1034 SBAR pasien yang diobservasi, 1018 SBAR lengkap. Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus atau tenaga kesehatan yang belum sepenuhnya menerapkan komunikasi efektif dengan metode SBAR.

Tabel 3.18 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Mei Tahun 2026

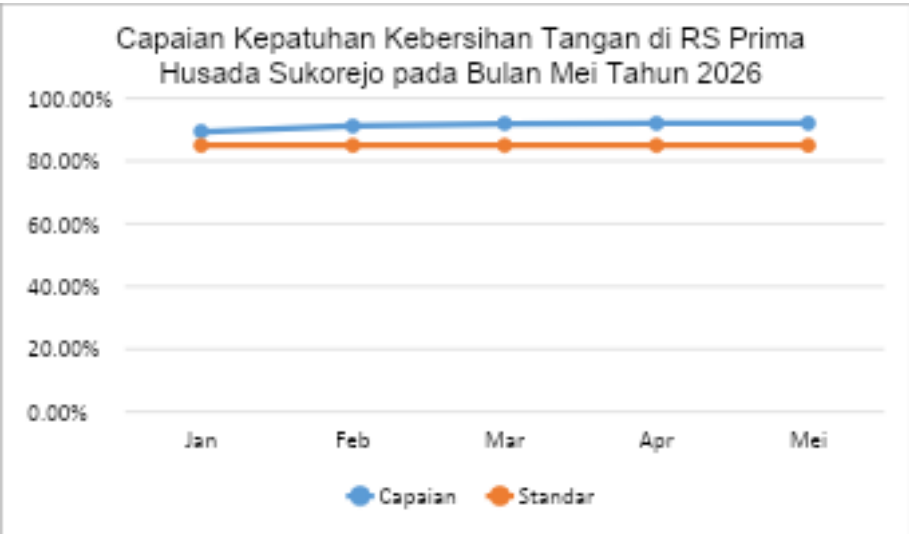
Problem	Capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif SBAR pada bulan Mei 2026 sebesar 98,47%, masih di bawah standar 100%. Dari 16 data tidak patuh, ditemukan masalah serius yaitu instruksi dokter via WhatsApp tidak dituangkan ke dalam form SBAR dan adanya form yang tidak ditandatangani oleh penerima pesan. Hal ini berisiko pada legalitas instruksi medis dan keselamatan pasien
Step	1. Audit Kepatuhan TBAK: Meninjau kembali prosedur Konfirmasi (TBAK: Tulis, Baca, Konfirmasi) termasuk saat melakukan visitasi dengan DPJP dan terdapat advice yang tersirat. 2. Review Rekam Medis: Mengidentifikasi unit-unit yang sering menerima <i>advice</i> tambahan namun lalai mencatatnya di lembar SBAR terintegrasi.
Plan	1. Objective: Mencapai kepatuhan 100% dengan fokus pada pendokumentasian instruksi verbal/pesan singkat 2. Strategi: Memperketat pengawasan terhadap instruksi "Advice Tersirat" agar wajib disalin ke form SBAR dalam waktu maksimal 1x24 jam dan ditandatangani. 3. Melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala
Do	1. Edukasi Khusus: Mengingatkan PPA bahwa instruksi yang tersirat tetap harus mengikuti prosedur SBAR/TBAK sebagai bukti legal di rekam medis. 2. Verifikasi Penerima: Mewajibkan kepala tim untuk mengecek kelengkapan TTD penerima pesan sebelum pergantian <i>shift</i> . 3. Kepala Ruangan mengecek kelengkapan TTD instruksi SBAR di setiap akhir <i>shift</i>
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada bulan Bulan Mei Tahun 2026 yakni 98,47%. 2. Hasil Analisis: Ketidakpatuhan (1,53%) disebabkan oleh kelalaian petugas untuk tidak segera melakukan SBAR pada saat ada tambahan saat visit dengan DPJP ataupun pesan melalui telfon. 3. Temuan: Adanya kelalaian staf untuk menuangkan hasil visit atau advice verbal dari DPJP.

Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini? Berdasarkan hasil pemantauan, rata-rata capaian Kepatuhan PPA terhadap Komunikasi Efektif menggunakan SBAR pada Bulan Mei Tahun 2026 yakni 98,47%. Capaian 98,47% belum memenuhi standar minimal 100% karena masih ditemukan instruksi verbal yang tidak dilakukan SBAR atau followup. Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Sosialisasi Prosedur "Advice Verbal": Menegaskan kembali bahwa instruksi verbal wajib dilakukan prosedur TBAK (Tulis, Baca, Konfirmasi) dan dicatat dalam rekam medis. 2. Audit Tanda Tangan Penerima: Mewajibkan Kepala Ruangan untuk melakukan <i>spot check</i> setiap akhir <i>shift</i> guna memastikan seluruh instruksi sudah ditandatangani oleh penerima pesan. 3. Pembinaan Personal "By Name": Memberikan edukasi lisan kepada 16 petugas yang teridentifikasi tidak patuh untuk memahami risiko hukum jika instruksi medis tidak terdokumentasi dengan lengkap. 4. Melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala
---------------	---

Tabel 3.19 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Diseminasi Data & Sosialisasi TBAK.	Memastikan PPA memahami bahwa instruksi verbal terutama saat asistensi DPJP harus disalin ke rekam medis (SBAR).	Seluruh Perawat, Bidan, dan Dokter.	Menekankan aspek legalitas rekam medis sebagai perlindungan hukum bagi PPA.	Komite PMKP	1 bulan
2	Supervisi Kelengkapan Administrasi (TTD).	Menghilangkan <i>gap</i> administratif pada kolom tanda tangan penerima pesan.	Berkas Rekam Medis (Lembar SBAR/CPPT).	Melakukan kroscek antara advice DPJP, SBAR PPJA dengan catatan di rekam medis.	Kepala Ruangan	1 bulan
3	Monitoring Pasca-Intervensi.	Mengevaluasi efektivitas edukasi terhadap pencapaian target 100%.	Unit Pelayanan Rawat Inap & IGD	Membandingkan data kepatuhan SBAR bulan Mei dengan Juni 2026.	Tim Mutu	Akhir Juni 2026

c. Kebersihan Tangan



Gambar 3.16. Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan data capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada Bulan Mei yakni mencapai 92,06%. Dari 1159 petugas yang diobservasi yang melakukan patuhan dengan benar yakni 1067 petugas. Capaian sebesar **92,06%** ini menandakan bahwa mayoritas petugas (1067 dari 1159 orang) telah menerapkan prosedur cuci tangan sesuai dengan protokol yang berlaku. Meskipun angka ini sudah berada di kategori tinggi, upaya monitoring dan evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan konsistensi dan mencegah resistensi dari petugas yang masih belum patuh.

d. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh



Gambar 3.17. Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Bulan Mei tahun 2026 adalah 98%, angka tersebut belum mencapai target 100% namun sudah meningkat dari bulan sebelumnya. Dari 1503 pasien yang diobservasi, 1473 pasien dilakukan upaya pencegahan resiko jatuh secara benar.

Tabel 3.20 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada

Tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan pencegahan risiko pasien jatuh pada bulan Mei 2026 sebesar 98% , masih di bawah target mutlak 100% . Dari 1503 pasien, terdapat 30 pasien (2%) yang tidak mendapatkan perlindungan risiko jatuh secara standar. Berdasarkan audit visual, ditemukan: 1. Pasien risiko tinggi tidak ada tanda risiko jatuh di bed pasien. 2. <i>Handrail</i> tempat tidur tidak terpasang/terkunci. 3. Kurangnya edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan jatuh. 4. Tidak identifikasi gelang pasien dengan risiko jatuh
Step	Audit Logistik: Memastikan ketersediaan stok stiker risiko jatuh di setiap <i>nurse station</i> . Pengecekan Fasilitas: Melakukan inspeksi terhadap kondisi <i>handrail</i> tempat tidur di seluruh ruang perawatan untuk memastikan fungsi kuncinya masih baik.
Plan	Objective: Mencapai tingkat kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar 100% pada periode audit berikutnya melalui penguatan pengawasan fasilitas dan edukasi keluarga. Strategi: Optimalisasi Penandaan: Mewajibkan pemasangan tanda resiko jatuh pada tempat tidur segera setelah skor asesmen menunjukkan risiko tinggi. Praktik DRK : Merefleksikan masalah atau temuan untuk menemukan akar masalah dan cara strategis untuk menanggulangnya
Do	Pemasangan Atribut: Petugas wajib memasang stiker kuning di bed pasien segera setelah asesmen awal menunjukkan skor risiko tinggi. Edukasi : Perawat memberikan edukasi singkat kepada keluarga pasien mengenai cara menjaga <i>handrail</i> tetap terpasang dan cara memanggil bantuan dan didokumentasikan pada ERM. Refleksi : Staf melakukan refleksi dengan sejawat dalam DRK untuk menemukan sistematisa untuk meningkatkan pencegahan resiko cedera akibat pasien jatuh
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Ketidakpatuhan (2%) menurun dari bulan sebelumnya hal ini terjadi karena petugas sudah mulai mawas diri dengan melakukan edukasi tertulis dan melakukan supervisi pada setiap sarpras yang menyebabkan resiko jatuh pada pasien. 2. <i>Handrail</i> yang tidak terpasang sering kali disebabkan oleh keluarga pasien yang menurunkannya dan menjadi titik lengah perawat.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Bulan Mei Tahun 2026 belum sesuai standar yakni 98% Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Rapat Koordinasi Unit: Memaparkan temuan 30 staf tidak patuh tersebut dalam rapat unit sebagai pengingat risiko cedera kepala atau patah tulang jika pasien jatuh. 2. Evaluasi Kinerja: Nama petugas yang bertanggung jawab pada 30 kasus ketidakpatuhan tersebut diserahkan kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam penilaian kinerja bulanan. 3. Redesign Monitoring: Mewajibkan pengecekan <i>handrail</i> menjadi bagian dari <i>checklist</i> operan perawat setiap pergantian <i>shift</i>. 4. Praktik DRK : Merefleksikan masalah atau temuan untuk menemukan akar masalah dan cara strategis untuk menanggulangnya bersama

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rapat Koordinasi Unit	Meningkatkan kesadaran staf mengenai urgensi pencegahan cedera (patah tulang/cedera kepala) akibat jatuh.	Seluruh staf klinis di unit rawat inap.	Memaparkan data 30 pasien tidak patuh secara transparan sebagai bahan evaluasi dan pengingat risiko klinis	Komite PMKP	1 bulan
2	Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Personal.	Memastikan akuntabilitas staf dalam menjalankan	30 Petugas yang teridentifikasi tidak patuh.	Performance Integration: Menyerahkan data <i>by name</i>	Kepala Ruangan	1 bulan

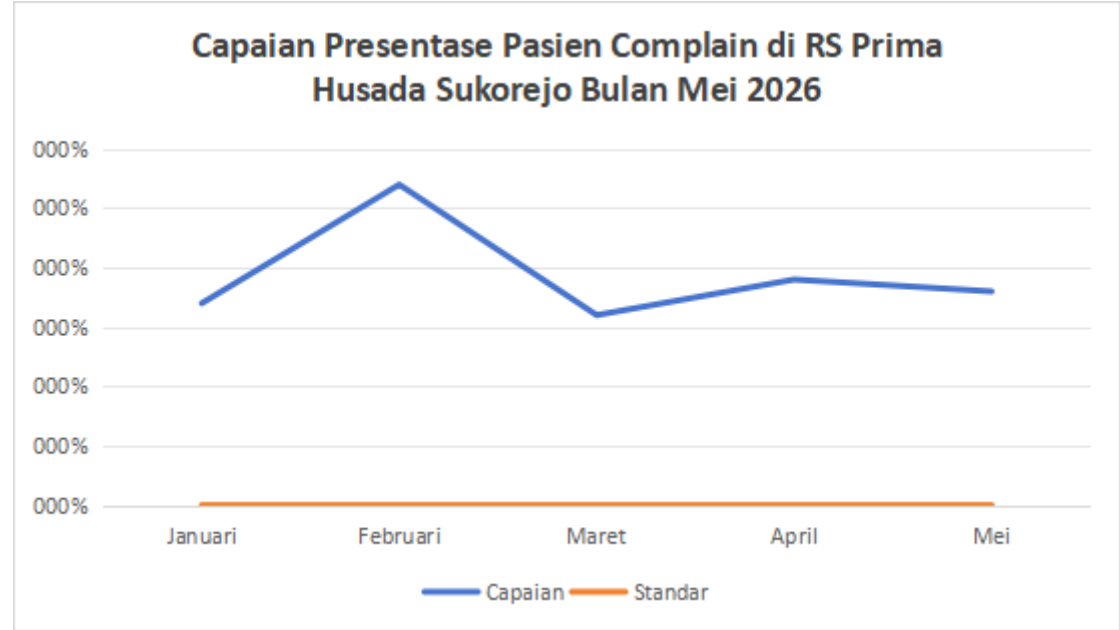
N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
		standar prosedur keselamatan pasien.		kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam poin penilaian kinerja bulanan.		
3	Redesign Monitoring melalui Checklist Operan.	Menjamin fasilitas keamanan (<i>handrail</i>) dan tanda risiko selalu terpasang di setiap pergantian <i>shift</i> .	Fasilitas tempat tidur pasien risiko tinggi.	Mewajibkan pengecekan fisik <i>handrail</i> dan stiker sebagai item wajib dalam <i>bedside handover</i> (operan di samping bed).	Perawat Pelaksana & Karu	1 bulan

2. Analisis Capaian Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
- a. Tingkat Kesesuaian Ukuran Tumor dengan Hasil PA

b. Kepatuhan PPK/CP Tumor Jaringan Lunak

c. Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning pada pasien DM sebagai upaya mitigasi komplain pasca rawat

d. Kepatuhan PPK/CP DM Tipe 2 dengan Komplikasi
3. Analisis Capaian Indikator Rencana Strategis RS
- a. Presentase Pasien Complain



Gambar 3.18. Capaian Persentase Pasien Complain di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian persentase komplain pada Bulan Mei tahun 2026 adalah 0,19%. Dari 11822 pasien yang datang terdapat 11 orang yang mengajukan komplain dari berbagai jenis platform yang berbeda.

Tabel 3.22 PDSA Capaian persentase komplain pada Bulan Mei Tahun 2026

Proble m	Capaian prosentase komplain pada bulan Mei 2026 sebesar 0,19%, masih belum mencapai target mutlak 0%. Dari 11822 pasien, terdapat 22 pasien yang tidak puas terhadap pelayanan maupun sarana prasana yang didapatkan. Berdasarkan telaah umum, ditemukan komplain ditujukan pada : 1. Respon yang lama dari petugas saat pasien ada keluhan 2. Pelayananandan/atau antrean yang lama 3. Sikap dan/atau tingkah laku staf yang dianggap tidak sopan
-------------	--

Step	Analisa Data dan Komplain : Melakukan analisis terhadap seluruh komplain yang masuk untuk dapat memetakan unit yang paling sering mendapatkan komplain Menentukan Prioritas : Memastikan MOD tanggap dalam merespon setiap komplain sesuai dengan grading sehingga komplain dapat ditelusur dan diselesaikan
Plan	Objective: Mencapai prosentase pasien komplain sebesar 0% pada periode audit berikutnya melalui telusur optimal dan efektif Strategi: Telusur optimal dan efektif melalui komunikasi dengan pasien untuk kemudian mengkonfirmasi pada unit atau staf terkait sehingga kejadian tidak terulang ataupun tertanggulangi.
Do	Respon Komplain: MOD dan Humas sebagai garda terdepan yang berhubungan dengan pasien, sehingga ketika ada komplain dapat dikategorikan, ditelusur, konfirmasi dan memberikan solusi cepat Kolaborasi : Merangkul staf untuk melakukan perbaikan sehingga komplain tidak terulang serta melakukan konsultasi segera ketika komplain yang ditujukan berdampak besar pada kehidupan rumah sakit
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. MOD memberikan tanggapan sesuai dengan kategori urgensi disertai dengan telusur, meski telah dilakukan penelusuran segera dan pemberian TL tetapi masih ada komplain dari pasien, dari Bulan Februari ke Bulan Maret ditemukan penurunan persentase namun komplain masih ada 2. MOD masih terkendala untuk menemukan akar masalah karena komplain yang disampaikan tidak spesifik sehingga masalah belum sampai pada tahap tindak lanjut
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian persentase komplain pasien terhadap pelayanan pada Bulan Mei Tahun 2026 belum sesuai standar yakni 0,19% Follow-up dan Rencana Lanjutan Rapat Koordinasi Unit: Memaparkan kepada unit bahwa masih ditemukan komplain dari pasien sebanyak 22 pengaduan yang beragam dari berbagai aspek. Koordinasi dengan seluruh unit untuk selalu memberikan edukasi pada setiap kegiatan yang beresiko komplain. Evaluasi Kinerja: Nama petugas yang bersinggungan atau diorientasikan pada 22 komplain tersebut diserahkan kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam penilaian kinerja bulanan ketika tidak terjadi perubahan dalam kurun waktu yang telah disepakati. Redesign Monitoring: Mewajibkan petugas untuk mengutamakan keramahan, responsif dan empati pada pasien saat melakukan perawatan maupun pelayanan

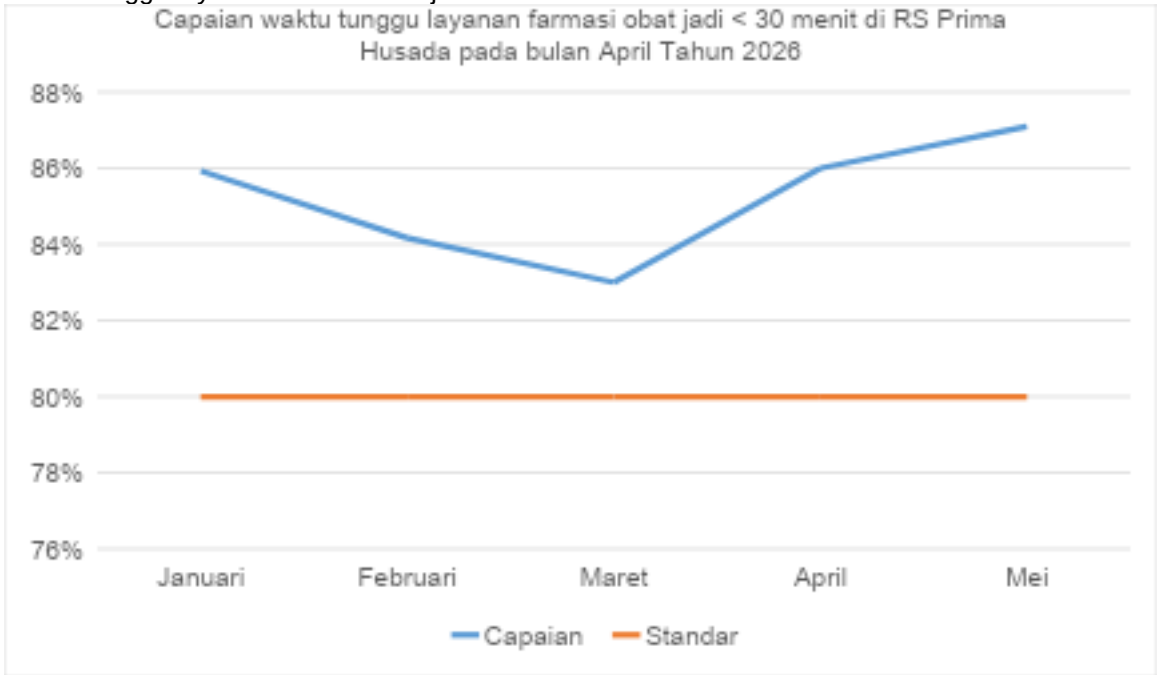
Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Rapat Koordinasi Unit	Meningkatkan kesadaran staf terkait efek yang dihasilkan dari komplain yang tidak tertangani atau berulang di unit kerja.	Seluruh staf	Memaparkan kepada unit bahwa masih ditemukan komplain dari pasien sebanyak 22 pengaduan yang beragam dari berbagai aspek. Koordinasi dengan seluruh unit untuk selalu memberikan edukasi pada setiap kegiatan	Komite PMKP MOD	1 bulan

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
				yang beresiko komplain		
2	Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Personal.	Memastikan akuntabilitas staf dalam menjalankan pelayanan.	Seluruh staf	Performance Integration: Menyerahkan data <i>by name</i> kepada Kepala Ruangan untuk dimasukkan ke dalam poin penilaian kinerja bulanan ketika ditemukan tidak ada perubahan dari sikap profesionalitas staf saat bertugas.	Kepala Ruangan	1 bulan
3	<i>Redesign Monitoring</i> melalui <i>Checklist</i> Operan.	Memastikan seluruh staf dapat mengutamakan kepuasan pasien saat pelayanan.	Seluruh staf pelayanan	Mewajibkan petugas untuk mengutamakan keramahan, responsif dan empati pada pasien saat melakukan perawatan maupun pelayanan.	Karu	1 bulan

4. Analisis Capaian Indikator Perbaikan Sistem

- a. Waktu tunggu layanan farmasi obat jadi < 30 menit

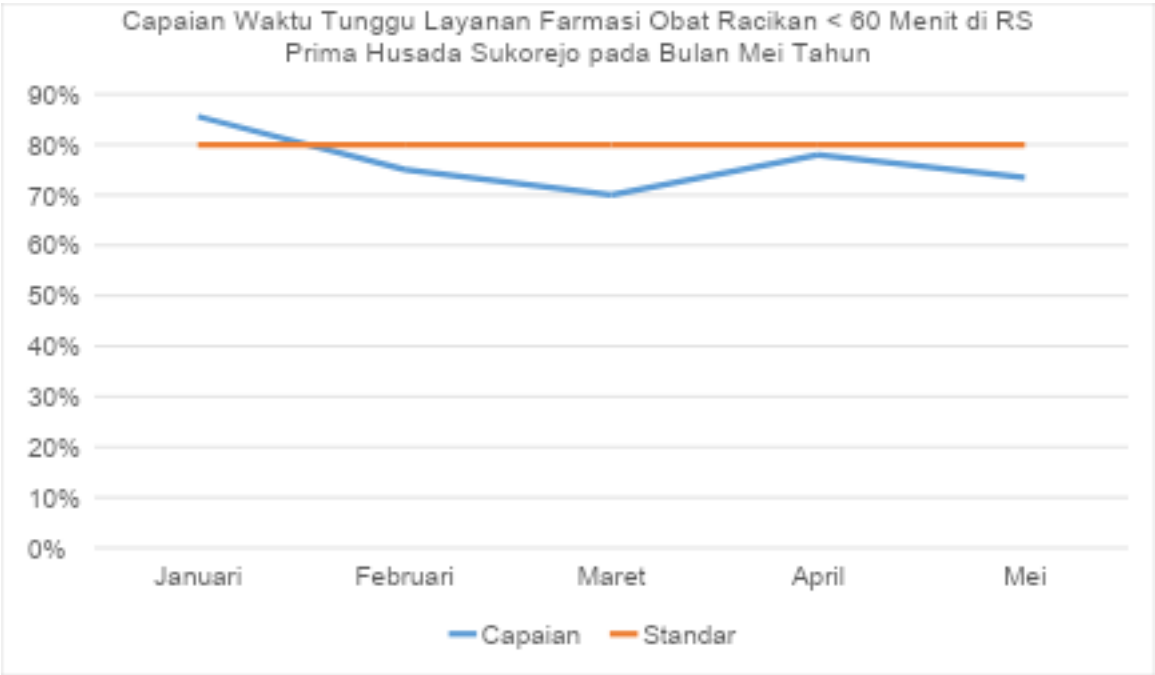


Gambar 3.17. Capaian Waktu Tunggu Layanan Farmasi Obat Jadi < 30 Menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun 2026

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian waktu tunggu layanan farmasi obat jadi < 30 menit pada Bulan Mei tahun 2026 adalah 85,24%. Angka tersebut telah mencapai target 80%. Dari 155 resep yang diobservasi, 135 resep yang selesai < 30 menit.

- b. Waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit



Gambar 3.18. Capaian Waktu Tunggu Layanan Farmasi Obat Racikan < 60 Menit di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada Bulan Mei tahun 2026 adalah 74,41%. Angka tersebut belum mencapai target 80%. Dari 155 resep yang diobservasi, 113 resep yang selesai < 60 menit.

Tabel 3.23 PDSA Capaian Waktu Tunggu Obat Racikan < 60 Menit pada Tahun 2026

Proble m	Capaian waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada bulan Mei 2026 sebesar 73,51%, masih di bawah target 80%. Dari 155 resep, terdapat 42 resep (25,59%) yang selesai > 60 menit
Step	1. Analisis Beban Kerja: Menghitung jumlah resep per petugas di jam sibuk 2. Observasi Alur (<i>Time Motion Study</i>): Mengamati di tahap mana (pengetikan, menumbuk, atau mengemas) yang paling lambat 3. Wawancara Staf: Mencari tahu kendala teknis yang dirasakan petugas
Plan	1. Menyediakan petugas khusus peracikan pada jam sibuk 2. Menyiapkan bahan dan kemasan racikan yang sering digunakan 3. Menggunakan sistem antrian dan pencatatan waktu (mulai–selesai) 4. Menginformasikan estimasi waktu tunggu kepada pasien 5. Melakukan briefing harian terkait pembagian tugas
Do	1. Menugaskan petugas khusus racikan pada jam puncak. 2. Mencatat waktu penerimaan resep dan waktu penyerahan obat 3. Menyediakan bahan racikan yang sering digunakan di area peracikan 4. Memberikan edukasi kepada pasien mengenai estimasi waktu tunggu
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada bulan Mei 2026 sebesar 73,51%, masih di bawah target 80% dan lebih rendah dari Bulan April 2026. 2. Penyebab belum tercapainya target waktu tunggu layanan farmasi obat racikan < 60 menit pada bulan Mei 2026 adalah penumpukan antrean racikan pada jam sibuk
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Mengusulkan penambahan SDM pada jam sibuk melalui pengaturan jadwal shift 2. Melakukan pelatihan efisiensi teknik peracikan 3. Menyusun daftar (formularium) obat racikan standar yang bisa disiapkan lebih awal (pre-compounding) sesuai regulasi 4. Mengoptimalkan manajemen beban kerja dan jadwal petugas

Tabel 3.24 Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasara n	Strategik	Pelaksana	Wakt u
1	Mengusulkan penambahan SDM pada jam sibuk	Memastikan ketersediaan petugas yang cukup untuk menangani lonjakan resep pada jam sibuk	Staf farmasi	Menganjurkan pengaturan jadwal SDM sesuai dengan jam sibuk	Kepala ruang farmasi & SDM Rumah Sakit	1 bulan
2	Mengembangkan sistem elektronik monitoring waktu tunggu	Memantau performa waktu tunggu secara akurat	SIMRS	Mengembangkan sistem elektronik yang mencatat waktu mulai resep masuk hingga obat siap serah secara otomatis	Tim IT & PIC Mutu Farmasi	1 bulan
3	Melakukan pelatihan efisiensi teknik peracikan	Meningkatkan kecepatan teknis peracikan	Staf farmasi	Mengadakan <i>workshop</i> teknik peracikan cepat dan penggunaan alat otomatis	Apoteker koordinator	1 bulan
4	Menyusun daftar (formularium) obat racikan standar yang bisa disiapkan lebih awal (pre-compounding) sesuai regulasi	Memangkas waktu proses persiapan obat	Stok obat	Menetapkan daftar racikan standar yang sering digunakan untuk disiapkan lebih awal sesuai regulasi kefarmasian	Apoteker koordinator	1 bulan

5. Analisis Capaian Indikator Manajemen Resiko

- a. Presentase berkas pending klaim
- b. Angka kerusakan alat medis karena ketidakpatuhan staf menjalankan SPO



Gambar 3.19. Capaian Angka Kerusakan Alat Medis Karena Ketidakpatuhan Staf Menjalankan SPO di RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan Mei Tahun

Analisis:

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata angka kerusakan alat medis karena ketidakpatuhan staf menjalankan SPO pada Bulan Mei tahun 2026 adalah 0. Angka tersebut telah mencapai target 0 kejadian.

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. INSTALASI GAWAT DARURAT

Tabel 3.25 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Bulan Mei Tahun 2026

N o	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	100%	100%	93,75%	96,61%								≥ 85 %	98,07%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	98,21%	98,79%	98,25 %	97,67%	90,53%								≥ 76,61 %	96,69%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	95%	100%								100%	99%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	99,36%	100%	100%	100%	100%								100%	99,87%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Instalasi Gawat Darurat <5 menit setelah pasien datang	100%	100%	100%	69,66%	100%								100%	93,93%	PDSA
2	Kematian pasien< 24 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	21	0	-	-	-								≤ dua per seribu		PDSA
3	Kelengkapan pengisian pengkajian medis E-Rm.	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4	Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan E-Rm.	100%	100%	100%	100%	96,77%								100%	99,35%	PDSA
5	Kelengkapan pengisian LOP	100%	100%	-	-	-								100%		Dipertahankan
6	Kelengkapan berkas triage E-RM pada pasien IGD	100%	100%	-	-	-								100%		Dipertahankan
7	Waktu Tunggu Pemasangan Gelang	93,55%	100%	100%	100%	100%								100%	98,71%	PDSA

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit															
8	Respon time pengantaran pasien P2 & P3 ke Rawat Inap < 3 jam	95,48%	100%	-	-	-								100%		PDSA

2. INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel 3.26 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Jalan pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	87,69%	90,41%	92,75%	90,28%								≥ 85 %	92,23%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	77,60%	70,48%	76,42%	77,60%	94,78%								100%	79,38%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	50%	100%	100%	100%								≥ 76,61%	90%	Dipertahankan
5	Waktu tunggu rawat jalan	98,12%	85,61%	100%	60%									≥ 80%	85,93%	Dipertahankan

6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	1005									100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan yang tidak sesuai dengan jadwal praktek dokter	32,70%	4%	96,23%	99,11%	Tidak diisi								0%	58,01%	PDSA
2.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal medis E-RM pasien rawat jalan	100%	100%	-	-	-								100%		Dipertahankan
3.	Kelengkapan pengisian pengkajian awal keperawatan E-RM pasien rawat jalan	100%	100%	-	-	-								100%		PDSA

3. INSTALASI RAWAT INAP 2A

Tabel 3.27 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2A pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	96,67%	97,39%	97,50%	97,50%	96,77%								100%	97,17%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Kepatuhan kebersihan tangan	87,58%	85,61%	82,58%	86,50%	87,74%								≥ 85 %	86%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	94,17%	96,52%	96,67%	97,50%	96,13%								100%	96,20%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	91,84%	92,50%	88,10%	87,50%								≥ 76,61 %	97,99%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	79,34%	80,17%	81,67%	80,83%	71,61%								≥ 80%	78,72%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	100%								≥ 80%	100%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	82,14%	100%	100%	94,59%								100%	95,35%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	95,83%	95,95%	95,83%	94,25%	96,97%								100%	95,77%	PDSA
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert					100%								100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	oleh petugas ranap															
3	Kepatuhan penandaan lokasi operasi di tubuh pasien					100%								100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	2,27%	0,63%	1,21%	1,25%	0,98%								≤ 0,24 %	1,27%	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	3 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	2 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≥24 Jam	94,21%	95,69%	96,64%	97,50%	98,06%								100%	96,42%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	95,83%	96,55%	100%	96,67%	79,35%								100%	93,68%	PDSA

4. INSTALASI RAWAT INAP 2B

Tabel 3.28 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 2B pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,71%	95%	100%	98,67%	98,06%								100%	98,09%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	88,54%	88,33%	89,36%	85,71%	90,32%								≥ 85 %	88,45%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	96,13%	95%	98,71%	96%	94,84%								100%	96,14%	PDSA
4	Kepuasan pasien	88,89%	83,54%	87,27%	90,32%	91,30%								≥ 76,61 %	88,26%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	53,55%	60%	60,65%	37,33%	58,06%								≥ 80%	53,92%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	100%								≥ 80%	100%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	82,35%	100%	98,92%								100%	96,25%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	96,13%								100%	99,23%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,75%	2,13%	1,52%	0%	0%								≤ 0,24 %	0,88%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	4 kejadian	6 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	1 kejadian								0 kejadian	4 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	2 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	85,81%	93,57%	86,45%	94,67%	86,67%								100%	89,43%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	97,42%	97,14%	97,42%	91,33%	89,03%								100%	94,47%	PDSA

5. INSTALASI RAWAT INAP 3A

Tabel 3.29 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3A pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	98,71%	98,57%	99,35%	99,33%	100%								100%	99,19%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Kepatuhan kebersihan tangan	80%	86,96%	95,71%	90,22%	92,86%								≥ 85 %	89,15%	Dipertahankan
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	98,06%	97,86%	98,06%	98,67%	100%								100%	98,53%	PDSA
4	Kepuasan pasien	(Tidak ada pasien yang mengisi barcode kepuasan pasien)	94,12%	100%	87,50%	94,03%								≥ 76,61 %	93,31%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	83,87%	91,43%	87,10%	85,33%	89,68%								≥ 80%	87,48%	Dipertahankan
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	93,75%	Tidak diisi	Tidak diisi	100%	Tidak lengkap								≥ 80%	97,91%	Dipertahankan
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	86,96%	100%	97,22%	100%	100%								100%	96,84%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	98,06%	98,57%	98,06%	98,67%	98,71%								100%	98,41%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap				96%	98%								100%	97%	
3	Kepatuhan penandaan lokasi operasi di tubuh pasien				100%	95%								100%	97,5%	
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0%	0%	0%	0%	0%								≤ 0.24 %	0%	Dipertahankan
2.	Kejadian pulang paksa	5 kejadian	3 kejadian	5 kejadian	2 kejadian	1 kejadian								0 kejadian	3 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	4 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	98,06%	97,14%	97,42%	97,33%	100%								100%	97,99%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

6. INSTALASI RAWAT INAP 3B

Tabel 3.30 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Rawat Inap 3B pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	90%	90%	90%	93,60%	88,39%								100%	90,40%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	85,96%	74,07%	87,10%	85,19%	90%								≥ 85 %	84,46%	PDSA
3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	94,07%	92%	87,50%	95,20%	92,67%								100%	92,29%	PDSA
4	Kepuasan pasien	100%	100%	100%	83,33%	86%								≥ 76,61 %	93,87%	Dipertahankan
5	Kepatuhan waktu visite dokter ≤14.00 WIB	45,97%	55%	54,55%	40%	71,61%								≥ 80%	43,43%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Tidak ada pengisian CP	Tidak ada pengisian CP	Tidak ada pengisian CP	Tidak ada pengisian CP	Pengisian CP tidak lengkap								≥ 80%	-	PDSA
7	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	97,44%	88,46%	96,97%	100%	100%								100%	96,57%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	90,83%	92%	90%	98,40%	92,90%								100%	92,83%	PDSA

2	Kepatuhan staf farmasi dalam penempelan stiker LASA dan High Alert					100%								100%	100%	Dipertahankan
3	Kepatuhan penandaan lokasi operasi di tubuh pasien					Tidak diisi										PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kematian pasien ≤ 48 jam	0,5%	0,75%	1,47%	1,29%	0%								≤ 0.24 %	0,80%%	PDSA
2.	Kejadian pulang paksa	2 Kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	66,92%	84%	84,17%	94,40%	89,68%								100%	83,83%	PDSA
5.	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	89,17%	88%	88,33%	91,20%	85,81%								100%	88,50%	PDSA

7. INSTALASI KAMAR OPERASI

A. Bedah

Tabel 3.31 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Bedah pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	83,87%	91,23%	100%	100%	96,77%								≥ 85 %	94,37%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100,00%	Dipertahankan
4	Penundaan operasi elektif ≥ 60 menit	2,14%	1,28%	1,14%	1,57%	2,81%								≤ 5%	1,79%	Dipertahankan
5	Kepuasan pasien													≥ 76,61 %		Dipertahankan
6	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan pelaksanaan <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart	100%	100%	-	-	-								100%		Dipertahankan
2	Kejadian tidak dilakukannya penandaan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	pada pasien operasi															
4	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor					-								≥ 90 %		Dipertahankan
5	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO	100%	100%	99,46%	100%	100%								100%	99,89%	Dipertahankan
2	Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
3.	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4.	Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari	100%	100%	-	-	-								100%	-	Dipertahankan
5.	Kejadian Kematian di meja Operasi	0 kejadian	0 kejadian	-	-	-								0 kejadian	-	Dipertahankan
6.	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
7.	Kejadian operasi salah orang	0 kejadian	0 kejadian	-	-	-								0 kejadian	-	Dipertahankan
8.	Kejadian salah tindakan pada operasi	0 kejadian	0 kejadian	-	-	-								0 kejadian	-	Dipertahankan
9.	Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 kejadian	0 kejadian	-	-	-								0 kejadian	-	Dipertahankan

B. Anestesi

Tabel 3.32 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi Anestesi pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kejadian reaksi anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
3	Kejadian salah penempatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian konversi regional	0 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	4 kejadian	5 kejadian								0 kejadian	2 kejadian	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	anestesi ke general anestesi															
6	Angka efek samping selama sedasi moderat	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

8. MATERNITAS

Tabel 3.33 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,56%	93,55%	100%	100%								100%	97,82%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	94,83%	97,37%	93,10%	93,75%	95,40%								≥ 85 %	94,89%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100,00%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan	97,85%	100%	100%	98%	100%								100%	99,17%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	Alat Pelindung Diri															
5	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	50%	60%	50%	44%	45%								> 80%	49,80%	PDSA
6	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	75,89%	76,85%	83,72%	76,99%	77,60%								≥ 80%	78,21%	PDSA
7	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	100%	100%	100%	100%	100%								≥ 80%	100%	Dipertahankan
8	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%								≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap			100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan pemberian MgSO4 pada pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3	Kejadian pasien dengan kasus PEB aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Kejadian pasien dengan Eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
6	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

9. PONEK

Tabel 3.34 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PONEK pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Upaya pencegahan	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

	resiko pasien jatuh															
3	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	94,44%	100%	94,44%	100%	80%								> 80%	93,78%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	100%	100%	Tidak ada yang mengisi survei	100%	Tidak ada yang mengisi survey								≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh Ponok				100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan pemberian MgSO4 pada pasien PEB	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	100%	100%	100%	100%	Tidak ada pasien HPP								100%	100%	Tidak ada pasien HPP di Ponok

3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh Tim ponek yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4	Persentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
5	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian kematian bayi di rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

10. NEONATOLOGI

Tabel 3.35 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Neonatologi pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	95,70%	87,50%	93,94%	92%	95,65%								≥ 85%	92,96%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100,00%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	95%	100%	100%								100%	99%	PDSA
5	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	70,97%	77,01%	63,83%	70,87%	77,27%								≥ 80%	70,67%	PDSA
6	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	-	-	-	-	-								≥ 80%		Tidak ada pasien dengan Diagnosa tunggal
7	Kepuasan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%								≥ 76,61%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan				100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

	High Alert oleh petugas ranap															
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	8 Kejadian	9 kejadian	7 kejadian	12 kejadian	2 kejadian								0 kejadian	7 kejadian	PDSA
2	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit)	100%	100%	100%	100%	Tidak ada pasien dengan VTP								100%	100%	Dipertahankan
3	Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-piece resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4	Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500- 2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
5	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

6	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA
7	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

11. ICU

A. ICU

Tabel 3.36 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU pada Bulan Mei Tahun 2026

No .	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100,00%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	89,29%	96,43%	96,77%	96,67%	96,77%								≥ 85%	95,19%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100,00%	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	30,77%	52,50%	34,38%	45,45%	42,11%								≥ 80%	41,04%	PDSA
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan perawat terhadap	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	komunikasi efektif menggunakan SBAR															
2	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ICU			100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	50%	0%	0%	0%								≤ 3 %	10%	PDSA
2.	Kepatuhan pengisian pengkajian form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

B. ICU ISOLASI

Tabel 3.37 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ICU Isolasi pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	100%	100%								100%	100 %	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	96,67%	96,77%								≥ 85%	96,72 %	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	100%	100%								100%	100 %	Dipertahankan
4	Kepatuhan Waktu Visit Dokter ≤14.00 WIB	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	0%	100%								≥ 80%	50%	PDSA
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	100%	100%								100%	100 %	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kepatuhan Waktu Pelayanan dokter di ICU isolasi (≤ 30 menit)	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	0%	0%								≥ 80%	0%	PDSA
2.	Kepatuhan Pembersihan dan desinfeksi ruangan	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	Tidak ada pasien	97%	96,45%								≥ 95%	96,45 %	Dipertahankan

12. RADIOLOGI

Tabel 3.38 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	100%								100%	20%	PDSA
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	100%	78,57%	Tidak diisi	-								≥ 85%		PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi								100%		PDSA
4	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	Tidak diisi	Tidak diisi								100%		Dipertahankan
5	Kepuasan pasien	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	-	-								≥ 76,61%		
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi								100%		PDSA
2.	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi								0%		PDSA
3.	Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi								0%		PDSA
4.	kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi	Tidak diisi								0 kejadian		PDSA

13. LABORATORIUM

Tabel 3.39 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,95%								100%	99,99%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Kepatuhan kebersihan tangan	84,62%	98,04%	90,74%	100%	97,96%								≥ 85%	94,27%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	69,23%	77,42%	89,53%	97,92%	92,45%								100%	85,31%	PDSA
4	Kepuasan pasien	-	-	-	-	-								≥76,61%		
5	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 60 menit kimia darah & darah rutin	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
3	Angka Kerusakan Sampel Darah	0,02%	0%	0%	0%	0%								0%	0,01%	PDSA
4	Angka ketidaklengkapan form permintaan laboratorium	3,95%	4,37%	2,83%	2,52%	2,36%								0%	3,21%	PDSA
5	Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
6	Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian Keterlambatan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Kejadian Keterlambatan Hasil Laboratorium CITO ≥30menit	0 kejadian	7 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	2 kejadian	PDSA
9	Kejadian Keterlambatan Penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
10	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfuse	100%	97,87%	100%	98,82%	98,85%								100%	99,11%	PDSA
11	Angka Reaksi Tranfusi Darah	0%	1,01%	0%	0%	0%								< 0,01%	0,20%	PDSA
12	Kejadian ED labu darah	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA

14. REHAB MEDIS

Tabel 3.40 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehab Medis pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	87,69%	90,41%	92,75%	90,28%								≥ 85%	92,23%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	100%	50%	100%	100%	50%								≥ 76,61%	80%	Dipertahankan
5	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	98,51%	100%	100%								100%	99,70%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	Kelengkapan pengisian pengajian medis & protokol pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
3	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4	Kepatuhan pengisian pengkajian reassesment setiap 2 minggu & akhir terapi	-	-	-	-	-								100%		Dipertahankan

15. FARMASI

Tabel 3.41 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Farmasi pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100,00%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	91,94%	89,80%	90,32%	87,80%	95,45%								≥ 85%	91,06%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100,00%	Dipertahankan
4	Kepuasan pasien	-	-	-	-	-								≥ 76,61 %		Belum diisi
5	Penulisan resep sesuai formularium	100%	95%	87,83%	100%									100%	96,57%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	85,93%	84,17%	83%	86%	87,10%								≥80%	85,24%	Dipertahankan
2	waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	75,56%	75%	70%	78%	73,51%								≥80%	74,41%	PDSA
3	Kepatuhan staf farmasi dalam penempelan stiker LASA dan High Alert			70%	73%	79%								100%	74%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
4	Kejadian kesalahan pemberian obat	0 kejadian	6 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	1 kejadian								0 kejadian	2 kejadian	PDSA
5	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	2 kejadian	1 kejadian	5 kejadian	6 kejadian	21 kejadian								0 Kejadian	7 kejadian	PDSA
6	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
7	Kejadian perubahan pemberian obat profilaksis menjadi teraupetik			0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
8	Ketepatan waktu pengiriman obat oleh vendor				96,62%	88,04%								≥95%	92,33%	PDSA

16. GIZI

Tabel 3.42 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100,00%	Dipertahankan
2	Kepatuhan kebersihan tangan	95,56%	100%	93,33%	87,30%	89,39%								≥ 85%	93,12%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	97,78%	88,89%	92,06%	90,20%	92,98%								100%	92,38%	PDSA
4	Kepuasan Pasien	91,80%	88,10%	89,74%	92,59%	90,12%								≥ 76,61%	90,47%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketepatan waktu pemberian	100%	100%	100%	100%	100%								≥ 90 %	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	makanan kepada pasien															
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	16%	16%	15%	16%	0%								≤ 20 %	12,60%	Dipertahankan
3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
4	Angka kelengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
5	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat	0%	0%	0%	0%	100%								100%	20%	PDSA

17. REKAM MEDIS

Tabel 3.43 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien				92%	96,13%								100%	94,06%	PDSA
2	Kepatuhan Kebersihan Tangan	100%	100%	100%	100%	100%								≥ 85%	100%	Dipertahankan
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4	Kepuasan Pasien	91,80%	-	-	-	-								≥ 76,61%		
Indikator Mutu Prioritas RS																
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	96,03%	95,80%	98,45%	94,62%	96,95%								100 %	96,37%	PDSA
2	Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	33,33%	65%	65,91%	58,14%	34%								100 %	51,28%	PDSA
3	Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda	3 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	4 kejadian								0 kejadian	2 kejadian	PDSA
4	Kejadian SEP tidak diterbitkan	1 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
5	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl)	96,77%	96%	96%	94%	95%								100%	95,55%	PDSA
6	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	33,90%	37,66%	44,29%	27,16%	12,26%								0%	31,05%	PDSA
7	Kelengkapan NIK di data pasien	97,19%	97,19%	96,83%	96,76%	99,16%								100%	97,43%	PDSA
8	Kelengkapan General Conccent	99,35%	100%	99%	-	-								100%	99,45%	PDSA
9	Kelengkapan berkas E-RM IGD	19,35%	21,43%	23,70%	16,67%	14,19%								100%	19,07%	PDSA
10	Ketepatan laporan dengan pihak eksternal	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

18. LIMBAH – K3RS

Tabel 3.44 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Limbah-K3RS pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Baku mutu limbah cair	a.BOD =10,06 mg/l	a.BOD =7,2 mg/l	a.BOD =10,07 mg/l	-	-								a.BOD < 12 mg/l	BOD =9,11 mg/l	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
		b. COD = 30,56 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l d. PH = 8,64 e. Faecal coli = 270	b. COD = 24,38 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l d. PH = 8,17 e. Faecal coli = 220	b. COD = 44,59 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l d. PH = 6,72 e. Faecal coli = 120										b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9 e. Faecal coli < 200	b. COD = 33,17 mg/l c. TSS = 5,40 mg/l d. PH = 7,84 e. Faecal coli = 203,33	
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	-	-								100 %	100%	Dipertahankan
3.	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	0%	0%	0%	-	-								100%	0%	1 Tahun
4.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	1 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	-	-								0 kejadian	1 kejadian	PDSA

19. SDM

Tabel 3.45 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit SDM pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staf	0%	0%	5,97%	3,73%	4,48%								100 %	2,83%	PDSA
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	0%	0%	0%	0%	0%								≥ 60 %	0,00%	1 Tahun
3.	Angka turn over staf	2,38%	1,50%	0,64%	1,30%	0,21%								≤10% / bulan	1,20%	Dipertahankan
4.	Angka keterlambatan staf ≥10 menit	25,11%	20,13%	31,12%	29,28%	56,99%								0%	32,52%	PDSA
5.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD : BLS/PPGD/GELS/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes g. NICU/PICU	69,41%	69,41%	69,41%	69,41%	69,41%								100%	69,41%	PDSA
6.	Kepuasan karyawan													≥ 80 %		semesteran

20. KESEKRETARIATAN

Tabel 3.46 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Ketepatan Pengumpulan UMANDOK 1 X 24 jam setelah selesai kegiatan	100%	100%	100%	100%									100%	100,00%	Dipertahankan
2.	Ketepatan waktu	100%	100%	100%	100%									100%	100,00%	Dipertahankan

	pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariat															
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	100%	100%	98,39%	100%									100%	99,60%	PDSA
4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	100%	100%	100%									100%	100,00%	Dipertahankan

21. DRIVER

Tabel 3.47 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Driver pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan waktu pengantaran penggunaan ambulance < 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100,00%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulace	100%	100%	100%	100%	100%								≥80%	100,00%	Dipertahankan
3.	Response time driver ambulance < 5 menit	99,05%	100%	100%	100%	100%								100%	99,76%	PDSA

22. PEMULASARAN JENAZAH

Tabel 3.48 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Pemulasaran Jenazah pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokumentasian pemulasaraan jenazah	100%	100%	100%	Tidak ada jenazah	Tidak ada jenazah								100%	100%	Dipertahankan

23. ATEM – IPSRS

Tabel 3.49 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit ATEM – IPSRS pada Bulan Mei Tahun 2026

No .	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
ATEM																
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	100%	100%	100%	100%	100%								≥80%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical ≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4.	Ketepatan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal	-	-	100%	-	-								100%	100%	Alat di Kalibrasi di Bulan September
IPSRS																
1.	Waktu pelayanan	95,71%	100%	100%	100%	100%								≥80%	98,93%	Dipertahankan

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	perbaikan alat non medis ≤ 24 jam															
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset ≤ 10 detik	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
3.	Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

24. LAUNDRY

Tabel 3.50 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan penggunaan APD	83,33%	85,71%	50%	100%	100%								100%	83,81%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kejadian linen yang hilang	3 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	7 kejadian								0 kejadian	2 kejadian	PDSA
2.	Kejadian terdapat benda asing di linen	3 Kejadian	3 kejadian	4 kejadian	3 kejadian	4 kejadian								0 kejadian	4 kejadian	PDSA

25. CSSD

Tabel 3.51 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan staf CSSD dalam menggunakan APD di area dekontaminasi	91,34%	93,48%	100%	100%	100%								100%	96,96%	PDSA
2.	Kejadian kertas steam indicator tidak berubah sesuai standar	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman	97,47%	90,27%	94,90%	100%	99,22%								100%	96,37%	PDSA (IGD, Poli, IRNA 2A)
4.	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse: 1. Breathing circuit 2. Begging 3. LMA 4. JR	-	-	-	-	-								100%	-	Hasil Swab Instrumen Negative
5.	Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
6.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertir cssd baik bersih dan kotor	97,47%	92,44%	97,96%	100%	99,22%								100%	97,42%	PDSA
8.	Kepatuhan unit dalam melakukan proses pengiriman dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan CSSD (kecuali cito)	96,23%	91,56%	96,43%	100%	99,21%								100%	96,69%	PDSA
9.	Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

26. CLEANING SERVICE

Tabel 3.52 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CS pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Penggunaan APD	93,06%	84,52%	91,40%	99,32%	94%								100%	92,46%	PDSA
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	80%	86,90%	92,47%	93,33%	88,39%								≥85%	88,22%	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kepatuhan clening service dalam membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius	100%	100%	99,47%	100%	100%								100%	99,89%	PDSA
2.	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%	99,89%	99,79%	100%	100%								100%	99,94%	PDSA
3.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis ≤3/4 Tempat sampah	100%	97,28%	98,40%	100%	100%								100%	99,14%	PDSA
4.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 3x dalam sehari	100%	99,89%	100%	100%	100%								100%	99,98%	PDSA

27. KEAMANAN

Tabel 3.53 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keamanan pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kejadian kehilangan barang milik pasien, penggungjung dan karyawan	2 Kejadian	3 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	1 kejadian								0 kejadian	2 kejadian	PDSA
2.	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4.	Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di Rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5.	Kejadian merokok di Area Rumah Sakit	615 kejadian	547 kejadian	615 kejadian	626 kejadian	509 kejadian								0 kejadian	583 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan penggunaan id card	87,85%	86,07%	87,85%	83,44%	81,18%								100%	85,28%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	pengunjung di area rumah sakit															

28. GUDANG UMUM

Tabel 3.54 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Gudang Umum pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	93,13%	90,91%	87,50%	100%	92,78%								100%	92,86%	PDSA
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	1,52%	2,89%	1,84%	0%	2,32%								0%	1,71%	PDSA
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

29. PPI

Tabel 3.55 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PPI pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	89,40%	91,13%	91,92%	92%	92,06%								≥ 85%	91,30%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan APD	96,54%	93,82%	94,98%	98,94%	97,15%								100%	96,29%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Komite PPI																
1.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	100%	100%	100%	100%	100%								100 %	100,00%	Dipertahankan
2.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	80%	83,21%	89,03%	89,67%	88,71%								75 %	86,12%	Dipertahankan
3.	Angka infeksi daerah operasi	0,27%	0,28%	0,29%	0%	0%								≤ 1,5%	0,17%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	96,88%	93,07%	100%	98,94%	90%								100%	95,78%	PDSA
5.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA
6.	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	97,02%	95%	96,13%	97%	96,45%								100%	96,32%	PDSA
7.	Kepatuhan petugas dalam	99,82%	93,28%	97,51%	97,47%	96,92%								100%	97%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)															
8.	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	95,14%	99,08%	98,98%	89,82%	91%								100%	94,80%	PDSA
9.	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100,00%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI	52,63%	52,63%	44,74%	60,53%	57,89%								100%	53,68%	PDSA

30. PKRS

Tabel 3.56 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS pada Bulan Mei Tahun 2026

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Angka pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam memberikan edukasi Kelompok	64,06%	64,06%	46,43%	54,69%	45,83								100%	55,01%	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2.	Angka pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
3.	Angka pelaksanaan survei ketepatan pengisian form edukasi terintegrasi oleh PPA	100%	100%	97,96%	100%	-								100%	99,49%	PDSA
4.	Kepatuhan staff dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)	64,06%	64,06%	53,13%	58,59%	60%								100%	59,97%	PDSA
5.	Kepatuhan Komunikasi efektif terkait SBAR-TBAK (Konsul DPJP, HO, rujuk internal, rujuk eksternal, konsultasi antar spesialis, pelaporan nilai kritis lab)	100%	100%	100%	97,62%	100%								100%	99,41%	PDSA

No	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
6.	Kepatuhan pembinaan komunitas berbasis RSPH (prognas dan geriatri)	100%	100%	33,33%	41,67%	100%								100%	75%	PDSA

31. ASURANSI CENTER

Tabel 3.57 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Asuransi Center pada Bulan Mei Tahun 2026

No .	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Me i	Ju n	Ju l	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s			
1.	Waktu Pengajuan Klaim	Tanggal 5	Tanggal 5	Tanggal 5	Belu m diisi									Tanggal 5	Tanggal 5	Dipertahanka n
2.	% Klaim Pending RJTL	0,04%	0,03%	0,02%	Belu m diisi									<0,1% dari total klaim	0,03%	Belum diisi
3.	% Klaim Pending RITL	6,97%	7,60%	7,57%	Belu m diisi									<1% dari total klaim	7,38%	Belum diisi
4.	% Klaim Tidak Layak	0,06%	1,06%	0,78%	Belu m diisi									0% dari total klaim	0,63%	Belum diisi
5.	Nilai Pengembalia n Audit Klaim RJTL	Rp1.141.761.70 0	Rp22.246.500	0	Belu m diisi									< Rp 1.000.000	Rp388.002.73 3	Belum diisi
6.	Nilai Pengembalia n Audit Klaim RITL	Rp4.163.300	Rp5.349.400	Rp4.661.900	Belu m diisi									< Rp 5.000.000	Rp4.724.867	Belum diisi

7.	Nilai Selisih Negatif Klaim RJTL	Rp56.592.940	Rp27.812.396	Rp27.812.396	Belu m diisi									< Rp 50.000.000	Rp37.405.911	Belum diisi
8.	Nilai Selisih Negatif Klaim RITL	Rp691.112.400	Rp424.814.88 0	Rp424.814.88 0	Belu m diisi									< Rp 100.000.00 0	Rp513.580.72 0	Belum diisi

32. HUMAS & MARKETING

Tabel 3.58 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepuasan Pasien MCU	26,47%	100%	100%	85,29%	Belum diisi								≥ 76,61%	75,49%	Dipertahankan
2.	Ketidakpatuhan perbaruan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	24,59%	24,59%	21,68%	18,03%	Belum diisi								0%	23,62%	PDSA
3.	Kenaikan jumlah Kerjasama dengan pihak eksternal	0%	0%	0%	0%	Belum diisi								10% / tahun	0%	Tahunan

33. CSO

Tabel 3.59 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSO pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Resptime CSO <30 mnt (WA)	9,93%	11,59%	10,89%	32,17%	34,01%								100%	19,72%	PDSA

34. MOD-MPP-PIPP

Tabel 3.60 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit MOD-MPP pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepuasan Pasien	91,80%	88,10%	89,74%	92,59%	90,12%								≥ 76,61%	90,47%	Dipertahankan
2	Respon time penanganan complain <5 menit	100%	96,15%	94,74%	81,82%	88,89%								100%	92,32%	PDSA
Indikator Mutu MOD-MPP-PIPP																
3	Angka kelengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	86,79%	50,33%	40,38%	50,92%	3,33%								100%	46,35%	PDSA
4	Angka kelengkapan form Dischard planning	86,79%	50,33%	40,38%	50,92%	3,33%								100%	46,35%	PDSA

35. TB di IRJA

Tabel 3.61 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TB pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi								100%	-	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
2	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien TB	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi								≥ 90%	-	PDSA

36. TIM HIV

Tabel 3.62 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit TIM HIV pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien HIV	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi	Belum diisi								≥ 90%	-	PDSA

37. KB

Tabel 3.63 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit KB pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan pengisian kartu K4 KB	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2.	Angka terlaksannya program KB pasca persalinan & pasca keguguran	26,89%	23,01%	21,01%	26,96%	21,85%								50%	23,94%	PDSA

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
3.	Semua ibu melahirkan dan curretage mendapatkan KIE KB	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	100%	100%	100%	100%	100%								30%	100%	Dipertahankan

38. STUNTING

Tabel 3.64 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Stunting pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	0%	0%	0%	0%								0%	0%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita1x dalam sebulan	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting	-	-	-	-	-								100%		Triwulanan PDSA

	dan wasting tiap 3 bulan sekali															
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	-	-	-	-	-								100%		

39. IT - SIM RS

Tabel 3.65 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IT – SIM RS pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1 kali	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tanggap penanganan internet dan billing error < 10 mnt	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
3.	Waktu tanggap untuk penanganan computer < 10 menit	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya 1 bulan sekali	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan

40. HEMODIALISA

Tabel 3.66 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Hemodialisa pada Bulan Mei Tahun 2026

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Indikator Mutu Nasional																
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	98,10%	100%	100%	100%								100%	99,62%	PDSA
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	94,83%	100%	97,37%	98,65%	95,77%								≥ 85 %	97,32%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	99,05%	100%	100%	100%								100%	99,76%	PDSA
4.	Kepuasan Pasien	100%	-	-	-	100%								≥ 76,61 %	100%	Dipertahankan
5.	Kepatuhan Penggunaan APD	100%	100%	98,46%	100%	95,16%								100%	98,72%	PDSA
Indikator Mutu Prioritas RS																
1.	Kejadian Tidak Adanya Label High Alert pada Obat	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1.	Kejadian Ketidaktepatan Pemasangan Akses Vaskuler	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian								0 kejadian	2 kejadian	PDSA
2.	Kejadian Hipotensi Intra Dialisis	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	1 kejadian	PDSA
3.	Kepatuhan Teknik Steril Perawat HD	100%	100%	100%	100%	100%								≥80%	100%	Dipertahankan

No.	Indikator	Bulan												Standar	Rata-rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial															
4.	Ketepatan Jadwal Hemodialisa	98,36%	93,88%	99,15%	99,17%	100%								≥95%	98,11%	Dipertahankan
5.	Kejadian Clotting Durante HD	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian								0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6.	Waktu Pelayanan perawat dari pasien datang sampai proses HD berjalan < 15 menit	95,52%	100%	100%	96,67%	97,56%								≥80%	97,95%	Dipertahankan